

CONCEITOS DE TEORIA E CLÍNICA EM FREUD - I

Curso de Formação em Psicanálise

psicanaliseclinica.com

VERSÃO - REVISÃO 2023-2024

MÓDULO II – TEORIAS DO APARELHO PSÍQUICO E ASPECTOS TEÓRICOS E CLÍNICOS NAS OBRAS DE SIGMUND FREUD I

Índice

Introdução	5
1. A trajetória de Sigmund Freud e suas principais contribuições	8
1.1. A origem de Freud	8
1.2. Freud e Charcot	13
1.3. Freud e Breuer	17
1.4. Primeira Tópica Freudiana (Modelo Topográfico)	21
1.5. Segunda Tópica Freudiana (Modelo Estrutural)	27
2. Os primórdios da psicanálise freudiana	33
2.1. A exploração das neuroses	34
2.2. Do hipnotismo à associação livre	41
2.3. Constructos teóricos a partir dos casos de histeria	52
2.4. Complexo de Édipo e Sexualidade Infantil	58
3. A interpretação dos sonhos e a constituição do aparelho psíquico	63
3.1 O livro do século e o conceito psicanalítico dos sonhos	64
3.2. O aparelho psíquico – primeiros passos	72
3.3. O aparelho psíquico – a descrição do modelo topográfico	77
3.3.1. O inconsciente (Ics)	79
3.3.2. O pré-consciente (Pcs)	81
3.3.3. O consciente (Cs)	83
3.3.4. A dinâmica das instâncias	86

3.3.5. O inconsciente e o cotidiano	90
4. O segundo modelo de aparelho psíquico	94
4.1. O ID	98
4.2. O SUPEREGO	101
4.3. O EGO	104
4.3.1. Os mecanismos de defesa do EGO	109
5. Breves reflexões acerca da Ética do Psicanalista	115
6. Quizzes (Enquetes)	119
7. Referências bibliográficas	134



IMPORTANTE

Estamos constantemente revisando e melhorando nosso material. Você está recebendo esta que é a nova versão da apostila do Módulo 2, atualizada para 2023-2024.

Nossos materiais são revisados e melhorados com certa frequência. Recomendamos que, após concluir o Curso, você revise os módulos já estudados: servirá para você aprofundar seu aprendizado e para verificar novas versões de nossos materiais.

Este material pertence ao Curso de Formação em Psicanálise Clínica (www.psicanaliseclinica.com). Sua divulgação paga ou gratuita não é permitida sem prévia autorização do nosso Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica (CNPJ 28.447.037/0001-81). Informe-nos qualquer uso não autorizado, pelo e-mail contato@psicanaliseclinica.com.

Introdução

Este é a apostila de base referente ao módulo II da parte teórica do curso. Nele você irá encontrar um panorama geral sobre o entendimento do conceito da psicanálise, a trajetória história de sua criação como a conhecemos, bem como os grandes nomes que contribuíram e/ou influenciaram para o desenvolvimento dessa ciência, campo de estudo e prática clínica.

Ao longo da apostila, logo ao final de alguns capítulos, estão indicadas leituras, vídeos e/ou filmes que são considerados obrigatórios para o curso de formação, haja vista a importância e relevância desses conteúdos no desenvolvimento profissional. Quando as leituras forem opcionais, haverá a indicação no próprio material.

Temos também vídeo-aulas e lives de revisão dos módulos (na área de membros), que resumem os assuntos dos módulos. Para fins de realização de prova, a leitura das apostilas é suficiente. Na fase final do Curso (Supervisão), isto é, após você concluir os 12 módulos teóricos, você terá encontros ao vivo por videoconferência (transmissões ao vivo por vídeo), em que serão debatidos estudos de casos, a dinâmica da clínica psicanalítica e suas técnicas, bem como serão revisados alguns conceitos teóricos essenciais à melhor interpretação dos casos.

À primeira vista, você pode pensar que a leitura desta apostila é muito extensa. Porém, a organização dos conteúdos foi feita para ser bastante

didática. Você vai perceber que a leitura flui bem, porque a apostila faz revisões frequentes, traz resumos, mapas mentais e enquetes, com o objetivo de fixar os conteúdos mais importantes.

Dedique-se ao máximo às leituras e demais materiais. Embora a formação on-line possibilite uma autonomia de tempo e andamento para a compreensão dos conteúdos, a qualidade da absorção e entendimento das temáticas, fundamentais à formação e prática profissional, dependem muito mais do comprometimento e seriedade com a qual você irá se dedicar.

Estamos adicionando quizzes ou enquetes nos módulos. Este módulo 2 já tem enquetes, ao final desta apostila. As enquetes servem para revisar e fixar conteúdos.

Importante: a prova do módulo (contendo 10 perguntas de múltipla escolha e uma redação) é diferente das enquetes (que são perguntas de verdadeiro ou falso). O que constata que você de fato terminou um módulo é fazer a prova deste módulo (10 questões de múltipla escolha + redação). Depois de ter feito a prova de um módulo, você já pode imediatamente começar o módulo seguinte.

ETAPA TEÓRICA



Conclua as Apostilas e as Provas dos 12 módulos teóricos (abaixo)



Mód. 1 | História e Fundamentos da Psicanálise

[Apostila e Vídeos](#) | [Prova](#) | [Materiais complementares](#)



Mód. 2 | O Aparelho Psíquico

[Apostila e Vídeos](#) | [Prova](#) | [Materiais complementares](#)



Mód. 3 | Libido, Pulsões e Sexualidade

A parte obrigatória do Curso de Formação são Apostilas + Vídeo e Provas (questões + redação) cujos *links* foram marcados com **flechas em vermelho (acima)**. Estude a apostila e faça a prova (10 questões + uma redação) para concluir um módulo (então, faça o módulo seguinte, até o módulo 12). Já os materiais complementares (indicados com **flechas azuis acima**) são opcionais.

Aproveite bem os materiais e bons estudos!

1. A trajetória de Sigmund Freud e suas principais contribuições

Ao pensarmos em Psicanálise, inevitavelmente nos remetemos a um famoso nome, Sigmund Freud (1856-1939). E não é à toa a sua fama, pela importância de Freud nos estudos da mente, das terapias, dos relacionamentos e da cultura.

O grande médico de Viena dedicou anos da sua vida à descoberta de uma área do conhecimento que reverbera e ecoa até os dias de hoje, sendo o principal impulsionador dos conteúdos psicanalíticos.

Para iniciarmos o caminho em busca do entendimento das ideias, conceitos e prática clínica freudiana, precisamos, primeiramente, compreender um pouco de sua história, ou seja, lançar um olhar à vida de Freud, sua criação, sua formação, seu contexto histórico e sua trajetória como grande nome do século XX.

1.1. A origem de Freud

No dia 6 de maio de 1856, na cidade Freiberg, até então pertencente ao Império Austro-Húngaro, nascia Sigmund Freud. Por ser a data de nascimento de Freud, aqui no Brasil costuma-se adotar a data de **6 de maio como Dia do**

Psicanalista (Lei Estadual SP n. 12.933/2008 e outras leis estaduais e municipais que fixam esta mesma data).

Filho de comerciante de lã que nunca obteve muito sucesso profissional, Freud mostrava uma relação ambivalente com seu pai, ódio misturado ao medo e à compaixão, bem como ao amor (**ambivalente**: mescla de pensamentos considerados moralmente positivos com pensamentos negativos a respeito de outra pessoa).

Na figura de sua mãe, uma dedicação muito afetuosa, apaixonante e sensual. Por ser filho de um segundo casamento de seu pai, Freud tinha mais dois meio-irmãos já adultos, sendo que um deles tinha um filho que tornou companheiro das aventuras infantis de Freud. A esses meio-irmãos e aos recém-chegados à família, havia um ressentimento recíproco muito grande.

Não por acaso, após a análise de toda a teoria freudiana, é possível perceber a influência do seio familiar na formação do indivíduo, seja na constituição em vida, seja na ausência em morte. Certamente as experiências manifestas em sua própria infância contribuíram, de algum modo, à sua forma de pensamento futura.

Biógrafos mais fervorosos de Freud, como **Ernest Jones**, defendem ainda que uma busca incansável por um significado para o homem e suas relações teria uma **gênese (origem)** em ligações familiares nos primeiros anos de vida de Freud.

Sem um rumo claro quanto às suas escolhas profissionais ao longo de sua vida acadêmica primária, o jovem Freud possuía sonhos infantis de se

tornar um general ou um ministro do Estado. No ano de 1873, Freud ingressa na Universidade de Viena com planos de se graduar em direito. Contudo acaba estudando na faculdade de medicina, mais em um sentido de adquirir conhecimento do que de aliviar sofrimentos (WOLLHEIN, 1971).

Em 1881, Freud é aprovado (tardamente) em seus exames na faculdade de medicina. Havia um interesse de Freud em não seguir a prática clínica como médico, mas sim um desejo em dedicar-se à pesquisa e ao ensino. Contudo, no ano seguinte, vê-se limitado a prosseguir com esse desejo em virtude de não possuir recursos financeiros para tanto.

Em 1882, conhece Martha Bernays, sua futura esposa e, pela primeira vez, ouve falar do **caso Anna O.**, descrito pelo médico Josef Breuer (MANNONI, 1994).

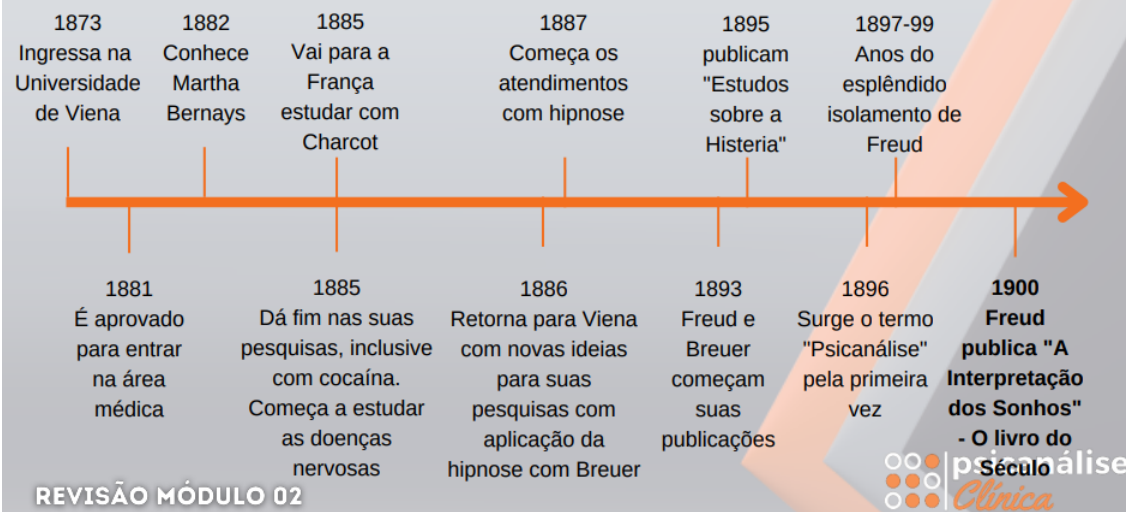
Nos anos subsequentes, aborrecido com a clínica geral, Freud dedicou-se à pesquisa especializada, passando por diversos departamentos dentro da Universidade de Viena, estudando, por exemplo, os órgãos sexuais das enguias, passando pela anatomia e histologia do cérebro humano, tendo contato, inclusive, com as teorias de **Charles Darwin**.

Ainda, dedica-se aos estudos relacionados à **cocaína**, buscando explorar suas propriedades analgésicas e anestésicas. Contudo não se mostra bem sucedido, apesar de ter o desejo de ser reconhecido por alguma descoberta. Nesse mesmo período, Freud dedica-se ao trabalho no tratamento de “**doenças nervosas**” através da eletroterapia.

Freud, descontente de suas escolhas e de seus feitos, decide que 1885 seria o ano da “grande virada de sua vida”. E de fato seria, porém não pelas motivações pelas quais ele estava convencido: seu casamento e a renúncia à pesquisa. Marcando esse momento, Freud destrói todos os seus papéis (trabalhos, anotações e diários) e assim sinaliza em uma carta para sua noiva Martha,

“Estou quase acabando de realizar um de meus projetos. É algo que certos infelizes que ainda não nasceram hão de lamentar um dia. Como você não vai adivinhar a quem estou me referindo, vou lhe contar: são meus biógrafos. Destruí todos os meus diários dos últimos quatorze anos, além das cartas, anotações científicas e dos originais de meus trabalhos... Todas as minhas reflexões e os sentimentos que me haviam inspirado o mundo em geral, e eu mesmo em particular foram declarados indignos de sobreviver. Será preciso repensar tudo isso de novo; e eu não tinha rabiscado pouco... Quanto a meus biógrafos, que se enfureçam! Não temos nenhuma intenção de facilitar-lhes a tarefa: cada um deles terá razão em sua maneira pessoal de explicar o desenvolvimento do herói.” (MANNONI, 1994, p. 21).

1.1 - A origem de Freud



INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

O blog do nosso projeto **Psicanálise Clínica** é considerado o maior conteúdo aberto de Psicanálise em língua portuguesa. Nele, publicamos artigos de professores, pesquisadores e de nossos alunos e ex-alunos. Os artigos são abertos a alunos e não alunos. Abordam temáticas cotidianas, culturais, de relacionamentos e comportamentos humanos, de transtornos, de teoria psicanalítica e de outras abordagens terapêuticas.

- **Acesse:** <https://psicanaliseclinica.com/blog>

Em algumas de nossas apostilas, indicaremos artigos relacionados aos assuntos do módulo. A leitura desses artigos é **opcional** para fins de prova, mas recomendamos que você busque sempre essas (e outras) fontes para se aprofundar nos temas abordados.

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- Artigo: [Ambivalência: significado em Psicanálise](#)
- Artigo: [Biografia de Freud: do início ao auge](#)
- Artigo: [Teoria da Evolução e Psicanálise](#)

1.2. Freud e Charcot

Nesse mesmo ano de 1885, Freud recebe uma bolsa de estudos e decide ir a Paris a serviço do renomado médico francês **Jean-Martin Charcot (1825-1893)**, o qual desenvolvia estudos sobre manifestações histéricas e os efeitos da sugestão. Não é incomum encontrar em biografias de Freud esse ano como sendo, de fato, um ano que mudaria suas concepções e noções em relação à prática médica, mas também o colocaria na direção da **psicopatologia** (isto é, os estudos sobre o que está na origem dos transtornos psíquicos).

Charcot, médico francês, renomado por seus estudos sobre a histeria e a sugestão hipnótica, foi tutor de Freud. Freud desempenhava função de assistente de Charcot, no início.

JEAN-MARTIN CHARCOT (1825-1893)



- ▶ Médico francês, renomado por seus estudos sobre a histeria e a sugestão hipnótica, foi tutor de Freud.
- ▶ Freud desempenhava função de assistente de Charcot, no início.
- ▶ É desta fase o método da **Sugestão Hipnótica**, primeiro método utilizado por Freud no atendimento a seus pacientes.

Durante sua passagem por Paris como assistente regular da clínica de Charcot, Freud pôde tirar três grandes lições que seriam de grande valor à sua jornada como a história contou (WOLLHEIM, 1971):

- A negação por parte de Charcot do entendimento da **histeria** como sendo uma doença atribuída à “imaginação” ou a uma irritação do útero (do grego “*hystera*”), como se acreditava até então. E, ironicamente, foi graças ao pensamento do médico de Paris que atribuída à **histeria uma relação com um distúrbio nervoso**, que Freud, durante muito tempo, se colocou contra a qualquer etiologia ou origem sexual para as neuroses (**etiologia**: estudo das causas das doenças).
- A descoberta de Charcot que, nas pessoas histéricas, **os sintomas não eram delimitados de acordo com a anatomia do**

sistema nervoso, ou seja, quando se paralisava uma perna, toda a estrutura ficava impossibilitada, mesmo que não fizesse parte do mesmo agrupamento neurofisiológico.

- A revelação de Charcot quanto à existência de uma **relação entre histeria e hipnotismo**, na medida em que os sintomas poderiam ser simulados aos pacientes por meio da **sugestão hipnótica**, os sintomas histéricos também poderiam ser removidos ou modificados através da hipnose. Ou seja, a mesma região do cérebro que gerava os movimentos histéricos involuntários geravam os movimentos de pessoas sob efeito da hipnose.

No ano seguinte, em 1886, Freud retorna à Viena onde monta uma **clínica de doenças nervosas**, entre as quais a histeria era uma das mais relevantes. No mesmo ano, e parte do seu plano de reviravolta em sua vida, Freud realiza um desejo há muito manifestado, **casa-se com Martha Bernays**, com quem tem, ao longo do matrimônio, seis filhos.

Em sua clínica nos anos iniciais, Freud lança mão de recursos e métodos físicos os quais confiava como a hidroterapia, eletroterapia, massagens, entre outros. Foi só ao final de 1887 que, em uma de suas primeiras cartas ao novo amigo, médico e futuro confidente e influenciador, **Wilhelm Fliess**, que Freud relata: *“mergulhei no hipnotismo e tenho tido toda a espécie de pequenos, mas peculiares êxitos”* (WOLLHEIM, 1971, p. 26).

De fato, Freud, em sua clínica, sobretudo no atendimento a histéricas, usa a **sugestão hipnótica como forma de buscar remover os sintomas perturbadores**, de igual maneira como havia aprendido em Paris com Charcot.

Contudo, como mesmo aponta o autor em “*Estudo autobiográfico*”,

“(…) desde o início fiz uso da hipnose de outra maneira, independentemente da sugestão hipnótica. Empreguei-a para fazer perguntas ao paciente sobre a origem de seus sintomas, que em seu estado de vigília ele podia descrever só muito imperfeitamente, ou de modo algum. Não somente esse método pareceu mais eficaz do que meras ordens ou proibições sugestivas, como também satisfazia a curiosidade do médico, que, afinal de contas, tinha o direito de aprender algo sobre a origem da manifestação que ele vinha lutando para eliminar pelo processo monótono da sugestão” (FREUD, 1925, p. 11).

1.2 - Freud e Charcot

- 1885 - Freud vai para Paris
- Três lições:
 - A histeria tem relação com um distúrbio nervoso
 - Os sintomas não eram delimitados pela anatomia
 - A relação entre histeria e hipnose
- 1886 - Retorna para Viena com novas ideias

REVISÃO MÓDULO 02

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- **Artigo:** [As influências de Charcot na obra de Freud](#)
- **Artigo:** [Método da Sugestão Hipnótica \(1º método de Freud\)](#)

1.3. Freud e Breuer

A figura de um famoso médico de Viena já conhecido por Freud volta à cena, **Josef Breuer**. Freud se lembra do **caso Anna O.** (nome verdadeiro: Bertha Pappenheim) há tempos atrás colocado por Breuer. E, com alguns anos de sua prática clínica, Freud e Breuer tornaram-se colaboradores de trabalhos relativos à histeria.

Desse modo, entre os anos de 1893 a 1896, os autores elaboram diversos textos referentes às **experiências provenientes da clínica**, como forma de caracterizar e conceituar achados pertinentes ao desenvolvimento da **nova forma de tratamento** encontrada.

Alguns deles como, “Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos: Comunicação preliminar” de 1893, os casos clínicos como o de Anna O., Emmy Von N., e Elisabeth Von R., podem ser encontrados em “**Estudos sobre a Histeria**”, de 1895, livro que traz conceitos teóricos e práticos vivenciados pelos autores, obra fundamental para o entendimento da gênese (origem) da psicanálise.

Contudo, a parceria científica ficaria com o avançar dos estudos, comprometida por divergências teóricas dos autores. De acordo com James Stranche em suas notas que abrem o livro “Estudos sobre a histeria”,

“(...) a principal diferença de opinião entre os dois autores, na qual Freud posteriormente insistiu, dizia respeito ao papel desempenhado pelos **impulsos sexuais na causação da histeria**. Também aqui, contudo, verificaremos que a divergência expressa aparece de uma forma menos clara do que seria de se esperar. A crença de Freud na **origem sexual da histeria** pode ser inferida com bastante clareza a partir da discussão em seu capítulo sobre a psicoterapia, mas em nenhum ponto ele chega a afirmar, como faria mais tarde, que uma etiologia sexual se mostra invariavelmente presente nos casos de histeria.” (FREUD, 1893, p. 14)

Ou seja, neste momento, Freud sugeria que os sintomas da histeria teriam causas originárias em transtornos psíquicos relativos a temas da sexualidade. Esta **interpretação sobre as origens reprimidas de transtornos psíquicos** marcaria um aspecto marcante da nascente teoria psicanalítica.

Para alguns autores da história de Freud, essa obra seria um marco inicial, a gênese da psicanálise. Aliás, foi nesse período, no ano de 1896, que Freud utiliza o termo “**psicanálise**”, na tentativa de estudar os componentes formadores da psique humana, compreendendo os fragmentos do discurso/pensamento e, então, destrinchar melhor os significados, implicações e repercussões na vida do indivíduo.

1.3 - Freud e Breuer

- 1893 - Freud e Breuer começam a publicar seus textos
- Uma nova forma de tratamento surge na área médica
- Vários casos foram atendidos por Freud e Breuer
- Se separaram por conta dos "*impulsos sexuais na histeria*"

REVISÃO MÓDULO 02

psicanálise
Clínica

O período que, segundo alguns biógrafos de Freud, ficou conhecido como **“autoanálise de Freud”** (para alguns autores vai de 1893 a 1899). Refere-se a um período em que Freud buscava compreender seus medos, anseios e dores. Este período permitiu descobertas importantes à psicanálise. A autoanálise de Freud partiu da associação livre, especialmente do que recuperava dos sonhos e das memórias da infância.

Intensificando em 1897, o que Freud chamaria de seu **“esplêndido isolamento”**, a psicanálise começa a ser sistematizada por Freud e, nesse contexto, ele inicia sua “autoanálise”, como forma, também, de entrar em contato com seus conteúdos psíquicos. Ou seja, o esplêndido isolamento corresponde ao período em que Freud focou suas atenções especialmente para um olhar sobre si, no decorrer de sua *autoanálise*.

“A auto-análise de Freud foi conduzida por meio de [análises de seus] sonhos, associação livre e memórias da infância. Foi espantosa sua habilidade nestes três aspectos. (...) Em mais de um sentido a auto-análise de Freud é a matriz a

partir da qual desenvolveu-se toda a ciência. Foi aqui que ele teve as grandes percepções, que formam a base da psicanálise.” (FINE, 1981, p. 28)

AUTOANÁLISE DE FREUD

(1893 a 1899)

psicanálise
Clínica

- ▶ O período conhecido como “autoanálise de Freud” refere-se a quando Freud buscava compreender seus medos, anseios e dores.
- ▶ Este período permitiu descobertas importantes à psicanálise.
- ▶ A **autoanálise de Freud** partiu da associação livre, especialmente do que Freud recuperava dos próprios sonhos e das memórias da infância.

Desse modo, descobertas fundamentais como o **inconsciente**, o **complexo de Édipo**, as **fases do desenvolvimento psicosssexual**, a **sexualidade infantil**, a **interpretação dos sonhos**, a **associação livre**, a **transferência** e a **resistência** são alguns dos achados mais valiosos da teoria e prática freudiana (FINE, 1981). Todos esses temas e casos serão retomados e aprofundados no decorrer de nosso Curso.

Nesse período, entre 1893 e 1899, Freud publica o intitulado “**Primeiras publicações psicanalíticas**”, contendo temas e textos importantes como “A

etiologia da histeria”, de 1896; “A sexualidade na etiologia das neuroses”, de 1898. Esses são estudos freudianos basilares na tentativa de avançar seus estudos sobre neuroses, em preparação para o que Freud consideraria “o livro do século”: “**A interpretação dos sonhos**”, publicado em 1900.

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- Artigo: [Lista de alguns filmes sobre Psicanálise](#)
- Artigo: [Josef Breuer e Sigmund Freud: relações](#)
- Artigo: [Método Catártico: o 2º método de Freud](#)
- Artigo: [Estudos sobre a Histeria \(de Breuer e Freud\)](#)
- Artigo: [O caso Anna O. analisado por Freud](#)
- Artigo: [O caso Emmy Von N. analisado por Freud](#)

1.4. Primeira Tópica Freudiana (Modelo Topográfico)

Esse foi um período de grandes avanços às discussões que Freud estava propondo, pois fora em “**A interpretação dos sonhos**” que o autor descreveu todo seu constructo referente ao funcionamento psíquico, na sua chamada **Primeira Tópica ou Modelo Topográfico** (fase inicial da teoria freudiana, em que o autor dividia a psique humana em Consciente, Pré-Consciente e Inconsciente).

O nome “**modelo topográfico**” deve-se à ideia de que essas instâncias do aparelho psíquico se estabeleciam em lugares (*topos*) da mente.

Sempre que falamos das Tópicas Freudianas, pensamos nas instâncias psíquicas da mente:

- **Primeira Tópica (teoria topográfica):** inconsciente, pré-consciente e consciente;
- **Segunda Tópica (teoria estrutural):** id, ego e superego.

Na Primeira Tópica (fase inicial do arcabouço freudiano), conceitos como a existência do **inconsciente**, a proposição de um **funcionamento do aparelho psíquico** (modelo topográfico), a influência da **sexualidade infantil** na formação da subjetividade do sujeito; a importância e a função dos **sonhos** para a organização psíquica, dentre outros pontos fundamentais para a psicanálise, marcam a obra do médico vienense.

Vale ressaltar, nesse período, o nome de um importante correspondente de Freud e que, de certa forma, o ajudou em seus constructos teóricos, graças às inúmeras cartas endereçadas a ele e que, também, compõem parte de sua obra, estamos falando do médico alemão **Wilhelm Fliess**.

Nos anos seguintes, e com o avançar de sua prática clínica, Freud apresenta produções de grande peso e repercussão para a época. Publicações como “**A psicopatologia da vida cotidiana**” de 1901, os “**Três ensaios sobre a teoria da sexualidade**” de 1905, além de fragmentos da análise de um caso de histeria, o que seria conhecido como “**Caso Dora**”, também em 1905. Essas

publicações acabam por dar visibilidade e notoriedade a Freud e à nascente psicanálise, que começam a ganhar espaço dentro do meio científico.

Nesse contexto, Freud começa a ser rodeado por estudiosos que veem seus achados dentro de um novo campo que estava emergindo. Nomes como Jung, Adler, Abraham e Ferenczi se associam a Freud e, em 1910, promovem o **I Congresso de Psicanálise**, que serve de base para a fundação da **International Psychoanalytical Association (IPA)**. Essa associação seria responsável por difundir a psicanálise, incentivar a formação de grupos ao redor do mundo, com o intuito de discutir, pesquisar e aprofundar o campo de estudos da psicanálise.

Não podemos esquecer o período histórico ao qual esse cenário se estabelece. É o momento da **Primeira Guerra Mundial (1914-1919)**, e esse grupo de psicanalistas acaba por suspender temporariamente as atividades dessa associação.

Contudo, não foi apenas a guerra que “minou” essa instituição recém-formada. Na medida em que Freud defendia e aprofundava seus estudos sobre a **sexualidade e sua repercussão na etiologia das neuroses**, bem como a **teoria da libido** e as bases dos mecanismos inconscientes ligados à sexualidade, nomes como Adler e Jung se posicionaram contrários a essas teorizações, o que levou à ruptura desses psicanalistas em relação à IPA, construindo suas próprias correntes de pensamento: a **psicologia individual (Adler)** e a **psicologia analítica (Jung)**.

“(...) a psicanálise tinha tido um grupo tristemente pequeno de seguidores. Na

Sociedade Psicanalítica de Viena, no número de membros em 1911-1912 era

de 34, e em nenhum outro país havia um grupo que chegasse de longe a este número. O temor de Freud, de que a ciência desapareceria, especialmente após a deserção de Jung e Adler, parecia ter bons fundamentos” (FINE, 1981, p. 70).

Apesar de tudo, importantes textos foram publicados por Freud nesse período, tais como, **“O caso Schreber”**, contido em “Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia” de 1911, **“Narcisismo”**, de 1914; **“Conferências introdutórias sobre psicanálise”**, de 1915-1916, revisitando seus conteúdos propostos até então; **“Luto e melancolia”** de 1917; **“História de uma neurose infantil”**, conhecida como “o homem dos lobos”, de 1918.

1.4 - Primeira Tópica Freudiana

- Modelo Topográfico
- A ideia de lugar
- Inconsciente, Pré-consciente e Consciente
- A sexualidade, os sonhos e o inconsciente
- Depois da publicação da obra "A Interpretação dos Sonhos", Freud ganha força e novos seguidores

REVISÃO MÓDULO 02

1.4 - Primeira Tópica Freudiana

- Em 1910, surge a IPA (International Psychoanalytical Association)
- A Primeira Guerra Mundial interfere nas publicações e nos estudos psicanalíticos
- Freud continua seus estudos

REVISÃO MÓDULO 02

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- Artigo: [Pré-consciente, Consciente e Inconsciente](#)
- Artigo: [Influência do Inconsciente no comportamento](#)
- Artigo: [Wilhelm Fliess: vida e contribuição](#)
- Artigo: [Caso Schreber analisado por Freud](#)
- Artigo: [Caso Dora analisado por Freud](#)



LIVES DO CURSO DE PSICANÁLISE

As lives são encontros ao vivo com nossos professores, em nosso Canal no Youtube. Todos os meses, trazemos de 3 a 4 novas lives. As gravações dessas lives ficam disponíveis para você na área de membros. De toda forma, é muito interessante se você puder participar ao vivo das lives, pela possibilidade de interagir via chat.

Agrupamos as lives por séries, a depender do assunto. Assim, temos (ou já tivemos) séries de lives sobre:

- **Leituras Freudianas:** a cada encontro, lemos e debatemos um texto diferente de Freud. Inclusive, muitas das leituras referem-se a conceitos e estudos de casos clínicos atendidos por Freud.
- **A Clínica Psicanalítica:** a cada encontro, apresentamos e debatemos um conteúdo teórico-prático relevante sobre o dia-a-dia da atuação do psicanalista em clínica e o *setting* analítico.
- **Cinema e Psicanálise:** a cada encontro, apresentamos e debatemos um filme diferente, sob o olhar da psicanálise.
- **Lives de Revisão dos Módulos da Formação:** a cada encontro desta série, revisamos assuntos essenciais de um dos 12 módulos do Curso.
- **Introdução a Winnicott:** encontros sobre as ideias teóricas e clínicas do psicanalista Donald Woods Winnicott.
- **Lives Especiais:** sem periodicidade definida (como as lives “Como Montar um Consultório” e “A prática da clínica psicanalítica”).

Além das lives de revisão, temos também as gravações das vídeo-aulas de todos os módulos. Todas as vídeo-aulas e gravações de lives estão disponíveis na área de membros.

A obra freudiana detalha muitos desses casos clínicos atendidos ou analisados por Freud. São importantes relatos escritos deixados por Freud e

que nos ajudam a entender a origem da psicanálise e a prática freudiana, mesmo quando sirvam de base para críticas e atualizações pela psicanálise de hoje.

Lista de todas as lives e o tema da próxima live:

<https://www.psicanaliseclinica.com/live/>

Acesse as gravações das lives já realizadas:

<https://membros.psicanaliseclinica.com/lives> (este link só funciona depois que você estiver logado com sua senha na área de membros).

1.5. Segunda Tópica Freudiana (Modelo Estrutural)

A retomada das atividades da IPA aconteceria em 1920, e, aos poucos, as pesquisas, os estudos e os encontros retornariam à rotina daquele agrupamento dos primeiros psicanalistas. Até metade da década de 1920, a teoria freudiana era estruturada sobre o **inconsciente** e a **libido**. Nesta época, Freud já mencionava a ideia de **id**. Foi entre as décadas de 1920 e 1930 que Freud traz uma reestruturação teórica, estruturando a personalidade humana sobre 3 bases: **o Id, o Ego e o Superego**.

O modelo anterior (topográfico ou 1ª Tópica), constituído pela ideia de inconsciente, pré-consciente e consciente, dá espaço ao **modelo estrutural** (ou 2ª Tópica) do funcionamento do aparelho psíquico visto por essas três instâncias: id, ego e superego. Não significa, no entanto, uma substituição

completa de uma tópica pela outra, já que Freud continuará empregando e ressignificando conceitos da Primeira Tópica (como inconsciente, consciente etc.).

O nome “**modelo estrutural**” atribuído à Segunda Tópica deve-se à ênfase não mais em “lugares”, mas sim no funcionamento e nas relações que as instâncias psíquicas estabelecem entre si. Cada instância não tem um valor absoluto em si, mas só pode ser compreendida pela comparação com as outras.

Associe:

	<i>Modelo</i>	<i>Instâncias</i>
<i>Primeira Tópica</i>	Topográfico	Ics, Pcs e Cs
<i>Segunda Tópica</i>	Estrutural	Ego, Id e Superego

Essa reformulação (Segunda Tópica) aparece no importante texto “**O ego e o id**”, de 1923; ano também marcante para Freud, uma vez que recebe o diagnóstico de câncer na mandíbula.

É nesse período, também, que Freud se dedica a alguns escritos que vão além da teorização da psicanálise. Há um movimento do autor, certamente devido ao momento histórico vivido, de construções textuais consideradas “**culturais**”, ou seja, que lançam um olhar ao contexto da sociedade da época. Escritos como “**O futuro de uma ilusão**”, de 1927, e “**O mal-estar na civilização**” (também traduzido como “O mal-estar na cultura”), de 1929, são

alguns dos exemplos da tentativa de Freud expor o pensamento psicanalítico ao seu tempo.

Entretanto, a história se encarregaria de influenciar novamente a trajetória da psicanálise e, “(...) à medida que começavam a cicatrizar as feridas da guerra, tornou-se evidente um novo espírito de otimismo, especialmente de 1925 a 1933; então Hitler pôs um fim a ele” (FINE, 1981, p. 77).

Em entrevista no ano de 1930, Freud desabafa seu amargor mesmo antes da ascensão de Hitler em 1933:

“Minha cultura e minhas conquistas são alemãs. Intelectualmente, me considerei alemão até perceber que os preconceitos anti-semitas iam aumentando na Alemanha e na Áustria. A partir daí, deixei de me considerar alemão. Prefiro definir-me como judeu.” (GLOBO, 2000).

Desse modo, em 1933, parte das obras de Freud são queimadas em praça pública. Depois, fugindo da perseguição nazista, Freud, aos 82 anos, tem seu exílio em Londres (em 1938), onde morre no ano seguinte, em 1939, vítima do câncer que o tinha acometido há anos.

1.5 - Segunda Tópica Freudiana

- Modelo Estrutural
- A ideia de movimento
- Id, Ego e Superego
- Algo deve movimentar aquilo que vem do inconsciente
- Entre 1920 e 1930 houve uma revisão teórica psicanalítica
- "O Id e o Ego" (1923)

REVISÃO MÓDULO 02

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- Artigo: [Ego, Id e Superego](#)
- Artigo: [Diferenciando Primeira e Segunda Tópicos freudianas](#)
- Artigo: [Freud em Londres: seu último ano de vida](#)

INDICAÇÃO DE VÍDEO:

- O JOVEM DR. FREUD - Documentário por "History Channel".

- [Ver a Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=1UqaHXxK9Ec](https://www.youtube.com/watch?v=1UqaHXxK9Ec)
- [Ver a Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=DZtRYqpxlGQ](https://www.youtube.com/watch?v=DZtRYqpxlGQ)

Os links para alguns vídeos e documentários podem ser removidos sem prévio aviso, pois são materiais hospedados por terceiros em sites de *streaming*. De toda forma, o aluno poderá buscar pelo título em outras fontes desses materiais, por meio de plataformas gratuitas ou pagas de hospedagem de vídeos ou em outros sites ou blogs.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE, VÁLIDA PARA TODAS AS "INDICAÇÕES DE LEITURA" ou "INDICAÇÕES DE VÍDEO":

Em "materiais complementares", você tem uma pasta com MATERIAIS OPCIONAIS (para você baixar e ler no longo prazo) e outra pasta de INDICAÇÕES DE LEITURA (nos quadrinhos "INDICAÇÃO DE LEITURA" ou "INDICAÇÕES DE VÍDEO", ao longo da apostila de cada módulo), que podem ser cobrados em prova e que precisam ser lidos para que os conceitos do Módulo façam sentido.

Os links de "indicação de leitura" ou "indicações de vídeo" estão inclusos no corpo da Apostila, como é o caso do material acima, e também podem ser achados na pasta INDICAÇÕES DE LEITURAS, na pasta "Materiais Complementares" de cada módulo.

Observe que alguns materiais na pasta INDICAÇÕES DE LEITURA não precisam ser lidos inteiros. Para saber quais páginas ler, veja na apostila de cada módulo.

2. Os primórdios da psicanálise freudiana

Uma vez traçado todo o percurso e trajetória da **vida** de Freud, compreendendo seus principais feitos, dificuldades, medos e realizações, chega o momento de explorar um pouco mais a sua **teoria**. Portanto, cabe o entendimento, também considerando sua história, de como os constructos teóricos foram sendo desenvolvidos a partir da sua vivência prática em estágios, palestras e conferências, além, é claro, da prática clínica posterior.

Segundo FINE (1981), a obra de Freud pode ser dividida em **quatro grandes períodos**:

- **Período de 1886 a 1895**: o início de sua prática, com a investigação da neurose considerando os estudos sobre a histeria (com Charcot e Breuer);
- **Período de 1895 a 1899**: sua autoanálise (período em que Freud dedicou-se a analisar a si mesmo);
- **Período de 1900 a 1914**: considerações sobre o Id e a libido, desenvolvendo seu primeiro modelo de aparelho psíquico (1ª Tópica);
- **Período de 1914 a 1939**: revisão de seus conteúdos, atribuindo relevância ao ego, e reestruturando seu modelo de aparelho psíquico (2ª Tópica).

Essa divisão didática tem por função principal organizar o pensamento freudiano na tentativa de compreender a importância e extensão de sua obra,

visto que o autor dedicou sua vida aos escritos que influenciaram e reverberam sobre a construção psicanalítica até hoje.

2 - Os primórdios da Psicanálise

- Período de 1886 a 1895: O início da Psicanálise
- Período de 1895 a 1899: período de autoanálise de Freud
- Período de 1900 a 1914: A constituição da Psicanálise
- Período de 1914 a 1939: A consagração da Psicanálise

REVISÃO MÓDULO 02



INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- Artigo: [As 4 grandes fases da obra de Freud](#)

2.1. A exploração das neuroses

Como é de conhecimento (apostila módulo 1, parte inicial), Freud começa sua trajetória como neurologista, mas logo se esbarra nas limitações do tratamento quando se referenciava a pacientes com sintomas de doenças nervosas ou **neuroses** (termo proposto por William Cullen, no século XVIII, para definir doenças que acarretavam em distúrbios de personalidade).

Na época da prática médica de Freud, final do século XIX, a medicina dispunha de dois métodos de tratamento para as neuroses: a **eletroterapia**, adotada por Freud, e o **hipnotismo**. Por meio de sua prática, Freud constata o fracasso da eletroterapia, e rende-se ao hipnotismo, em 1889, graças a sua visita a Bernheim, além, é claro, do seu estágio entre 1885 e 1886 com Charcot, no seu contato direto com pacientes histéricas.

E, nesse seu caminhar inicial, Freud tem a compreensão de que a chave para a neurose **não estaria nem na eletroterapia nem no hipnotismo**, mas sim nos estudos do funcionamento da mente e da psique: a **psicologia**. Era visível sua inquietação quanto à necessidade de buscar mais sobre os conteúdos psicológicos e sua relação com as psicopatologias, tais como a neurose, como forma de explorar esse campo na tentativa de elaboração de um constructo teórico. Em uma carta a Fliess, Freud discorre:

“Meu tirano é a psicologia. Sempre foi minha meta distante e tentadora, e agora, que avancei com as neuroses, ela se tornou muito mais próxima. Duas ambições me perseguem: ver como toma forma a teoria do funcionamento mental, se nela são introduzidas considerações quantitativas, uma espécie de economia da força nervosa; e, em segundo lugar, extrair da psicopatologia o que pode ser benéfico para a psicologia normal.” (25 de maio de 1895).

Desse modo, na década de 1890, Freud propõe e divide a neurose em dois conceitos, **neuroses atuais** e **psiconeuroses**.

- **Neuroses atuais:** são afecções patológicas que remetem à **frustração sexual**, ou seja, é atual, pois a origem da problemática estaria no atual momento do aparecimento do seu sintoma. Portanto, Freud descreve a *neurastenia* como sendo causada por masturbação excessiva; e a *neurose de ansiedade* (ou angústia) como sendo uma estimulação sexual não-d Descarregada.
- **Psiconeuroses:** são afecções patológicas que tinham origens em **traumas sexuais na infância**. Entre elas estariam a *histeria*, a *obsessão* (ou neurose obsessiva), e as *fobias*.

As **psiconeuroses** são patologias que se atualizam no presente por apresentar um representante psíquico vinculado ao passado. Segundo Freud, embora sua origem (etiologia) seja na infância, as decorrências podem perdurar pela vida adulta.

Para Freud, fobias são essencialmente psiconeuroses, relacionadas a eventos traumáticos da infância que encontram substitutos fóbicos.

PSICONEUROSES

- ▶ São patologias que se atualizam no presente por apresentar **um representante psíquico vinculado ao passado.**
- ▶ Segundo Freud, embora sua origem (etiologia) seja na infância, as decorrências podem perdurar pela vida adulta.
- ▶ Para Freud, as **fobias** são essencialmente psiconeuroses, relacionadas a eventos traumáticos da infância que encontram substitutos fóbicos.

Já as **neuroses atuais** são patologias que possuem um correspondente vinculado às frustrações sexuais, pelo excesso ou inibição, e não apresentam origem na infância.

Freud não rejeita outras patologias, como as patologias psicóticas, nem rejeita a definição de psicose (que, aliás, não é uma neurose).

NEUROSES ATUAIS

- ▶ Neuroses atuais são patologias que possuem um correspondente vinculado às frustrações sexuais, pelo excesso ou inibição, e não apresentam origem na infância.
- ▶ Para Freud, há dois tipos principais de neuroses: as **Neuroses Atuais** (aqui explicadas) e as **Psiconeuroses**.

Vale lembrar, sobretudo, que essas distinções entre psiconeuroses e neuroses atuais acabaram se tornando obsoletas, apesar de Freud não indicar com exatidão tais contrapontos. De fato, esses conteúdos integram sua obra “**Publicações pré-psicanalíticas e esboços inéditos (1885-1889)**”, mas, como mesmo desejou Freud, a grande obra inaugural da psicanálise seria iniciada por “**Interpretação dos Sonhos (1900)**”. (FINI, 1981)

Ainda nesse contexto, o escrito “**As neuropsicoses de defesa**” (1894) acaba por ser uma produção muito importante para esse momento de descobertas e organização de ideias, na qual um entendimento extraído pareceu ser fundamental e que, de certa forma, concede um sentido à história da psicanálise: “***todas as neuroses representam uma defesa contra ideias insuportáveis***”.

Em outras palavras, uma neurose surge porque um evento insuportável ao estado consciente atrapalharia demais a vida do indivíduo, se este indivíduo se lembrasse disso o tempo todo. Por isso, esse evento precisa ser recalcado, isto é, precisa deixar de estar “presente”, precisa ser “esquecido”.

Mas tal evento não pode ser de fato totalmente esquecido: sua memória “fiel” está recalcada, mas ainda vive na forma de manifestações indiretas, como os sintomas produzidos pela neurose. Os sintomas são símbolos (*sinais colocados no lugar*) conscientes de algo que foi recalcado no inconsciente: daí a Psicanálise ser um **saber interpretativo ou hermenêutico**, pois vai pesquisar as origens desses sintomas (teremos módulos específicos do Curso que aprofundarão as neuroses e psicoses).

É inegável que a **histeria** foi de grande importância para a trajetória inicial de Freud em sua clínica psicanalítica, e à histeria vamos nos atentar um pouco mais. As experiências com Charcot, Bernheim e Breuer, além de sua constante reflexão sobre os casos clínicos, possibilitaram a Freud a elaboração de um constructo teórico próprio, bem como propiciaram o desenvolvimento de uma técnica para além da hipnose: a **associação livre**.

2.1 - A exploração das neuroses

- Neuroses - termo cunhado por William Cullen - médico britânico, no século XVIII
- Freud e a medicina
- A eletroterapia e a hipnose

Neurose → **Neuroses atuais** - frustração sexual
→ **Psiconeuroses** - trauma sexuais infantis

REVISÃO MÓDULO 02

2.1 - A exploração das neuroses

“Todas as neuroses representam uma defesa contra ideias insuportáveis”.

REVISÃO MÓDULO 02

2.1 - A exploração das neuroses

"Sua memória "fiel" está recalçada, mas ainda vive na forma de manifestações indiretas, como os sintomas produzidos pela neurose. Os sintomas são símbolos (sinais colocados no lugar) conscientes de algo que foi recalçado no inconsciente"

REVISÃO MÓDULO 02



INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- Artigo: [Neuroses atuais e Psiconeuroses](#)
- Artigo: [Sobre a Histeria de Conversão](#)

2.2. Do hipnotismo à associação livre

Os constructos feitos por Freud nesse período inicial da sua clínica, sobretudo com as teorizações sobre as neuroses, certamente partiram da proposta terapêutica da hipnose que figurava, emblematicamente, na pessoa do Dr. Josef Breuer.

Para o renomado médico Dr. Breuer, cabia a hipótese de que a histeria se caracterizava pela **retenção de certas lembranças**; e, a cada lembrança, haveria um **correspondente sintomático físico**. Por exemplo, a lembrança de um trauma da infância poderia provocar em alguns pacientes movimentos físicos involuntários.

Contudo, em nível consciente, as ideias “retidas” não pareciam se associar ao sintoma. Somente através do **estado hipnótico**, era possível o acesso à lembrança, torná-la consciente e, então, o sintoma se extinguiria. A esse procedimento, Breuer atribui à alcunha de “método catártico”. (MANNONI, 1994).

Associe assim os **três métodos de atendimento clínico** usados por Freud ao longo de sua carreira:

Método	Ideias-chave	Parceria de Freud com
(1º) Sugestão Hipnótica [saiba mais]	Estado hipnótico, sugestões para o paciente se lembrar ou para superar um transtorno.	Jean-Martin Charcot (em Paris)
(2º) Catártico [saiba mais]	Similar ao 1º + suscitar emoções extremas no paciente + técnica da pressão*.	Josef Breuer (em Viena)
(3º) Associação Livre [saiba mais]	Diálogo terapêutico (em um <i>setting</i> analítico) baseado na fala “livre” do paciente e na atenção flutuante interpretativa do analista.	Freud <i>solo</i> (é o método definitivo de Freud e da psicanálise atual)

* **Técnica da pressão**: às vezes empregada por Freud e Breuer; conhecida como um recurso incremental do método catártico. Consiste em **o analista pressionar com o seu polegar a testa do paciente**, como uma forma de favorecer a rememoração pelo

paciente. Ao abandonar o método catártico, Freud abandonará também a técnica da pressão.

Era interessante notar como Breuer usava a hipnose, para entender a origem da doença. No **caso Anna O.**, Breuer pôde, sintoma a sintoma, verificar uma correspondência com alguma experiência passada, enquanto a paciente estava em estado hipnótico. Por exemplo, a paciente apresentava uma incapacidade de beber água e, durante a investigação realizada no tratamento, pode-se remeter a uma imagem da infância, a qual a paciente entra em seu quarto e olha um cachorro bebendo água em um copo.

Desse modo, ao se descobrir a associação do fato subjetivo ao sintoma apresentado, o mesmo desaparecia quando a paciente voltava ao estado consciente.

Com isso, Breuer constata que um sintoma pode ser curado apenas conversando a seu respeito durante um estado hipnótico, uma vez que a eficácia do método estaria na descoberta da causa originadora do sintoma.

Freud, por sua vez, acaba por utilizar esse método hipnótico em seu início de carreira, como uma **maneira catártica**, ou seja, na revelação emocional da origem correspondente ao sintoma. Nesse aspecto, Freud evoluiu no tratamento com as ditas pacientes “histéricas”, mulheres que manifestavam sintomas físicos sem acometimentos fisiológicos (ou seja, sem causas físicas para suas doenças) que justificassem a patologia. Podemos pensar que

“(...) a histeria ocorre porque é experimentado um evento, provavelmente de caráter doloroso, e a recordação dessa experiência não se dissipa nem perde a sua valência, em qualquer das formas normais. Essas formas são enumeradas como “ab-reação” (que significa, em poucas palavras, ser descarregado através da emoção concomitante), inclusão num complexo de associações ou simplesmente, experimento. Uma recordação resiste a esses processos naturais quer pela natureza do evento, do modo que a pessoa, ao tentar esquecê-lo, o reprime, o que é uma forma de preservá-lo; quer pela natureza do estado psíquico da pessoa quando experimentou o evento – ela encontrava-se num estado hipnoide ou semi-hipnoide.” (WOLLHEIM, 1971, p. 31).

Veremos mais adiante que Freud abandonou o método hipnótico, por considerar que o diálogo terapêutico por meio da associação livre seria suficiente para alcançar o inconsciente de seus pacientes. Entretanto, Freud manteria em sua teoria a ideia de Breuer e do hipnotismo daquela época, de que **tornar consciente um fato inconsciente tinha um efeito “curativo”**. Ou seja, lembrar ou revelar o que está recalcado extingue os sintomas, tanto no ponto de vista do hipnotismo quanto no ponto de vista da associação livre.

2.2 - Do hipnotismo à Associação Livre

**“Tornar consciente um fato inconsciente
tinha um efeito “curativo”.”**

REVISÃO MÓDULO 02

psicanálise
Clínica

Certamente, algumas das primeiras experiências de Freud no tratamento das histéricas, foram fundamentais para as mudanças na utilização das técnicas até então experimentadas.

Foi assim com a Sra. **Emmy Von N.**, que com a sua frase direta à Freud: “pare de me fazer perguntas e me deixe falar”, pode proporcionar ao analista o entendimento de que sugestões à paciente, ou a explicação “racional/lógica” dos sintomas e/ou fantasias, não estava sendo efetivos ao tratamento.

CASO EMMY VON N.

(PACIENTE DE FREUD) 

- ▶ **"Pare de me fazer perguntas e me deixe falar"** (frase atribuída a Emmy Von N., paciente de Freud).
- ▶ Trata-se de um caso clínico fundamental para que Freud atribuísse relevância à **fala do paciente**.
- ▶ É uma paciente do período do **método catártico** (Breuer & Freud). Inspirou Freud a valorizar a fala do paciente, um passo na direção do que viria a ser o método da **associação livre**.

Na associação livre, o paciente pode falar sobre temas variados. O analista não deve repreender as mudanças de assunto na fala do paciente. A **atenção flutuante** do analista ajuda a interpretar padrões.

Em 1892, Freud inicia o tratamento de **Elisabeth Von R.** que, enquanto paciente histérica, se mostra não ceder às técnicas de hipnose. E, após tentativas frustradas de sugestionar a fala da paciente, Freud a encoraja a dizer tudo o que viesse à sua mente. A esse método Freud mantinha-se receoso, haja vista que por vezes a paciente se silenciava ou algo atrapalhava seu fluxo de associação de pensamento.

2.2 - Do hipnotismo à Associação Livre

- A histeria e os traumas de infância
- Charcot e a sugestão hipnótica
- Breuer e o Método Catártico
- Freud e a Associação Livre
- A técnica da pressão na testa
- O sintoma sempre se conectava com algo do passado

REVISÃO MÓDULO 02

psicanálise
Clínica

Ora, para Freud, portanto, mantinha-se a ideia de que havia algum fato importante que a paciente conhecia, mas que por algum motivo, não deveria ou não poderia ser acessado, como quando, no início da análise, relata sentir atração por um jovem não identificado. E, ao longo do tratamento, as constatações de Freud aparecem quando a paciente relata sentir-se atraída pelo seu próprio cunhado e, no leito de morte de sua irmã, lhe ocorre o pensamento: “agora ele está livre, posso ser sua esposa”. A esse fenômeno Freud dá o nome de **repressão**, ou seja, uma defesa da mente a esses conteúdos que não poderiam ser acessados.

Desse modo, e graças ao seu olhar perspicaz para com o andamento do tratamento dos seus pacientes, Freud acaba por desenvolver um método, conhecido como **associação livre**, estando, portanto, atento à construção da fala do paciente, seus significados, propósitos e intenções, na tentativa de compreender as significações por trás do encadeamento das ideias, enquanto mergulhava no universo do inconsciente.

O INÍCIO DO MÉTODO

DA ASSOCIAÇÃO LIVRE psicanálise Clínica

- ▶ Para Freud, sugestões hipnóticas e conselhos unilaterais do analista não eram suficientes no tratamento.
- ▶ Freud passou a **deixar o paciente falar mais**, para que este desencadeasse ideias de forma mais livre.
- ▶ Ao fomentar a fala livre do paciente, Freud buscava significações potencialmente relacionadas ao **funcionamento do inconsciente**.

Falar sobre uma dor psíquica é uma forma de abrir o discurso para elaborar uma compreensão sobre eventos ou padrões inconscientes originários à dor. Assim, **a associação livre não se baseia:**

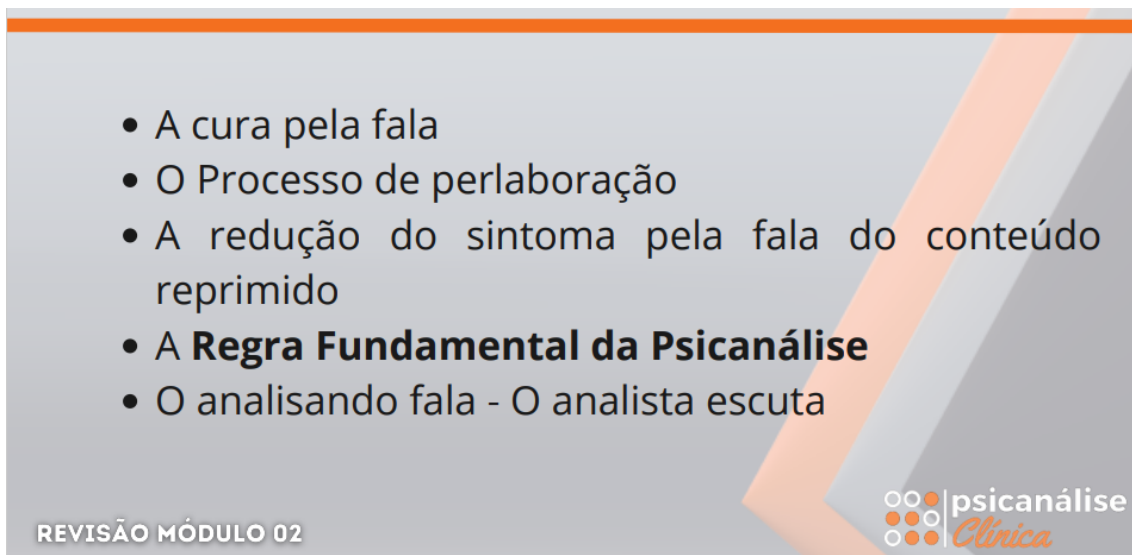
- na fala puramente lógica e intencional do analisando;
- em aconselhamentos sobre o que o analisando deve fazer;
- na hipnose nem em estado hipnótico ou sugestivo.

Para Freud, sugestões hipnóticas e conselhos unilaterais do analista não eram suficientes no tratamento.

Assim, na transição em direção à associação livre, vão se tornando relevantes também os silenciamentos e as contradições. Faz-se em estado de “vigília”, sem uso de hipnose.

Freud passou a incentivar a “fala livre do paciente”, de modo a possibilitar a busca pelas significações potencialmente relacionadas ao funcionamento do inconsciente.

Compreendendo o método da associação livre:



- A cura pela fala
- O Processo de perlaboração
- A redução do sintoma pela fala do conteúdo reprimido
- A **Regra Fundamental da Psicanálise**
- O analisando fala - O analista escuta

REVISÃO MÓDULO 02



Então, sobretudo em função do **método da associação livre**, a Psicanálise passa a ser conhecida como “a cura pela palavra”, pois Freud pressupõe que falar sobre (a rigor) qualquer assunto pode levar a “pistas” interpretativas que conduzem ao conteúdo reprimido.

E, uma vez descoberto este conteúdo reprimido, os sintomas perderiam em parte seu poder e permitiriam o processo de **perlaboração**, isto é, a ressignificação feita pelo paciente a partir dos *insights* compreendidos na sessão psicanalítica.

Embora, na origem, Freud tenha experimentado métodos derivados da hipnose (a saber, a sugestão hipnótica com Charcot e o método catártico com

Breuer), **a psicanálise atual usa somente o método da associação livre**. A hipnose, a sugestão hipnótica, a técnica da pressão e o método catártico foram importantes na fase inicial de Freud e na gênese da psicanálise, mas não são técnicas da psicanálise atual.

Ainda que, durante uma sessão psicanalítica, as **perguntas** (usadas para “abrir o discurso”) feitas pelo analista ao paciente sejam relevantes como recurso discursivo para “abrir o discurso do analisando” e permitir novas reflexões, a fala do psicanalista no *setting* analítico não se resume apenas a fazer perguntas para o analisando responder. Isto é, perguntas podem ser parte da técnica. Mas não resumem todo o trabalho do analista. O analista também identifica resistências e propõe possíveis interpretações a partir de palavras que emergem do discurso do analisando.

Importante, ainda, ressaltar que a **atenção flutuante não é um outro método da psicanálise diferente da associação livre**. A atenção flutuante é, na verdade, um componente essencial *dentro do método da associação livre*.

Assim:

- enquanto a parte do analisando é **livre-associar**,
- a parte que compete ao psicanalista é manter sua **atenção flutuante** (para permitir a livre-associação e para captar conteúdos relevantes à interpretação).

LIVRE ASSOCIAÇÃO

E ATENÇÃO FLUTUANTE

- ▶ O paciente **livre-associa**, trazendo os conteúdos que lhe vêm à mente.
- ▶ A **atenção flutuante** do analista ajuda a interpretar padrões.
- ▶ A associação livre não se baseia na fala puramente lógica do analisando. São relevantes também os silenciamentos e as contradições.
- ▶ Faz-se em **estado de "vigília"**, sem uso de hipnose.

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- Artigo: [Transição de Freud: da hipnose à associação livre](#)
- Artigo: [Caso Elisabeth Von R. \(analisado por Freud\)](#)
- Artigo: [Alguns estudos de casos analisados por Freud](#)
- Artigo: [Recalque, repressão e censura](#)
- Artigo: [Como funciona o método da Associação Livre?](#)

2.3. Constructos teóricos a partir dos casos de histeria

Apresentada a contextualização histórica sobre a **gênese psicanalítica**, é importante salientar que foi nesse início de trabalho analítico que Freud, buscando tornar como uma ciência, escreve o texto “**Projeto para uma psicologia científica**”, em 1895, porém com publicação apenas em 1950. E, certamente, com os casos relativos à histeria que o médico vienense começa a estruturar sua teoria psicanalítica, desenvolvendo conceitos a partir dos achados em sua clínica.

Neste sentido, podemos dizer que a obra freudiana é de base empírica, isto é, origina-se muitas vezes das necessidades de analisar casos clínicos do próprio Freud, além, é claro, das pesquisas de Freud em outras áreas do conhecimento, sobretudo nos estudos culturais.

A experiência de Breuer com o **caso Anna O.** foi fundamental para que Freud evoluísse em seus conceitos. Freud tinha conhecimento de que a paciente sofria de cólicas abdominais (provenientes de uma fantasia de parto), e lembrava, pelas palavras de Breuer, que a paciente havia dito: “**Agora é o filho de Breuer que está chegando**”.

2.3 - Os casos de histeria

- Um método empírico analisado através de casos
- Os casos atendidos por Breuer e Freud
- A transferência para o analista
- Resistência e Contratransferência

"O paciente transfere seus conflitos inconscientes para a figura do analista"

REVISÃO MÓDULO 02



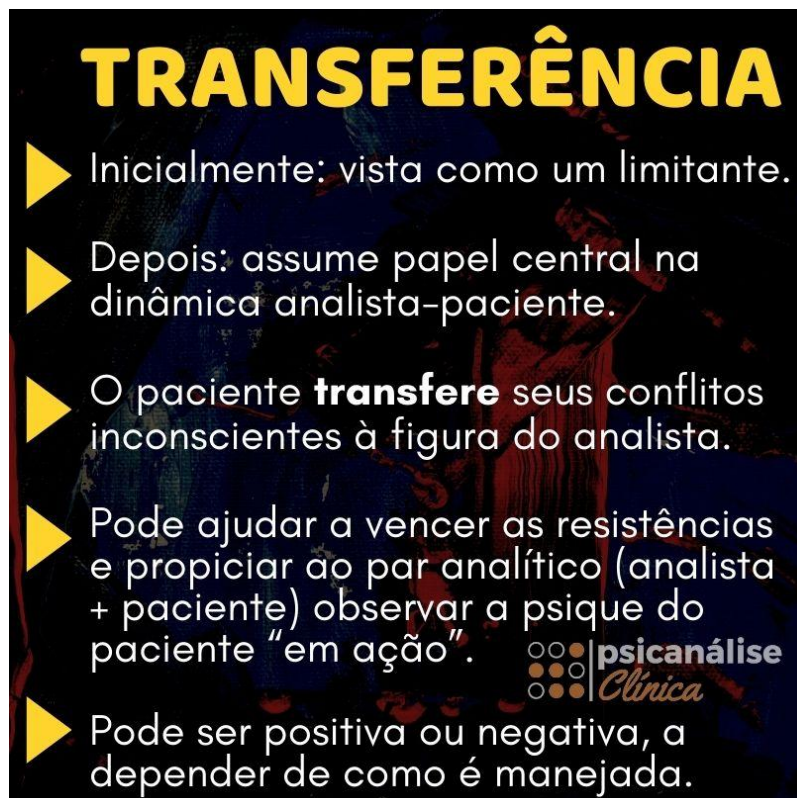
Como resultado, Breuer abandona sua paciente, uma vez que sentiu muita culpa por essa, e outras, manifestações que a Anna O. lançava sobre a figura do analista. Seria, portanto, o início do entendimento, por Freud, do conceito de **transferência**.

Nesse contexto, a transferência seria compreendida à primeira vista como sendo um **limitante ao tratamento analítico**. Isto é, se a Psicanálise dependia da relação empática e afetiva entre analista e analisando (paciente), ela não teria uma suficiência comprovada em si mesma, como método cientificamente validado. A ideia inicial de transferência é que esta dependeria da afinidade entre analista e paciente. Então, como garantir que essa afinidade não teria um caráter ilusório e temporário, como na terapia baseada em hipnose?

Com o avançar das teorias freudianas, o conceito de transferência vai sendo melhor elaborado. Passa a ser visto como tendo papel fundamental na dinâmica entre o paciente e o analista.

Vê-se que a transferência pode ter um **caráter positivo ao avanço do tratamento**, ao significar que:

- o paciente está se sentindo **mais seguro para livre-associar**, trazer seus desejos, demandas, angústias etc.
- as **resistências do paciente estão menos ativas**, já que o paciente de certa forma passa a agir com o analista de forma similar ao que agiria com pessoas de sua “vida real” (como com um pai, mãe etc.);
- essa **maior naturalidade do paciente no setting analítico**, representada por uma *transferência* do lugar de pai (mãe etc.) para a figura do analista (isto é, tratando o analista como um pai, uma mãe etc.), pode ser favorável ao tratamento, por trazer mais ideias e materiais a serem interpretados.



TRANSFERÊNCIA

- ▶ Inicialmente: vista como um limitante.
- ▶ Depois: assume papel central na dinâmica analista-paciente.
- ▶ O paciente **transfere** seus conflitos inconscientes à figura do analista.
- ▶ Pode ajudar a vencer as resistências e propiciar ao par analítico (analista + paciente) observar a psique do paciente “em ação”.
- ▶ Pode ser positiva ou negativa, a depender de como é manejada.

No **caso de Anna O.**, por exemplo, a transferência para com Breuer ocorre em função dos **conflitos inconscientes infantis da paciente**, que, neste caso, estariam na fantasia da paciente pelo seu desejo do amor paterno, que ela transfere para a figura do analista.

Desse modo, podemos pensar a transferência como sendo,

“(...) o processo pelo qual os desejos inconscientes se atualizam sobre determinados objetos* no quadro de certo tipo de relação estabelecida com eles e, eminentemente, no quadro da relação analítica. Trata-se aqui de uma repetição de protótipos infantis vivida com um sentimento de atualidade acentuada (...). (LAPLANCHE E PONTALIS, 1967/1996, p. 492).”

Importante: quando a psicanálise fala em “objeto”, não pense apenas em “coisas inanimadas”. Objetos podem ser também *pessoas*. Um objeto do afeto, por exemplo, é a pessoa que recebe nosso afeto (o destino do afeto).

A **transferência**, dentro da dinâmica na relação do **par analítico** (paciente-analista), pode ser positiva ou negativa.

- É **positiva** quando a energia libidinal (de origem afetiva ou erótica/sexual) é dirigida ao analista, repetindo-se os conteúdos (conscientes e inconscientes) de seu passado infantil.
- É **negativa** quando há transferência de conteúdos/sentimentos hostis, carregados de agressividade, dificultando e bloqueando o trabalho da análise.

Em síntese, podemos dizer que a **transferência pode ser positiva** quando permite romper resistências e o paciente se coloca aberto a refletir sobre isso. E é **negativa** quando a transferência traz resistências a mais (como quando o paciente não permite olhar para si mesmo e não avança além de um amor ou ódio pelo analista).

Assim, inicialmente vista como um limitante, a transferência assume papel central na dinâmica analista-paciente, uma vez que o paciente transmite seus conflitos inconscientes à figura do analista e, desta forma, pode favorecer muitos materiais para o trabalho psicanalítico.

A transferência pode ser importante para ajudar a vencer as resistências e propiciar ao par analítico (analista + paciente) observar a psique do paciente “em ação”.

Transferência não significa “transferir de psicanalista” (mudar de psicanalista), nem significa “analista e paciente trocarem de lugar”. Em vez de romper a terapia ao primeiro “ruído”, o conceito de transferência pensará os ruídos como parte em potencial da terapia, se bem manejada.

Outro conceito fundamental que apareceria nessa época (e também relacionado aos desdobramentos dos estudos sobre a histeria) estaria ligado à dificuldade do analisando em atingir seus conteúdos mais profundos, estamos falando da **resistência**.

Resistência é um nome amplo para vários mecanismos conscientes ou principalmente inconscientes que levam o paciente a rejeitar um confronto mais profundo consigo, inclusive durante as sessões de terapia.

Foi no **caso de Elisabeth Von R.** que Freud pôde compreender que alguns mecanismos de defesa se revelavam durante a fala do paciente, funcionando como uma espécie de *censura*, atrapalhando, inclusive, o desencadeamento do pensamento.

“A resistência aparece na clínica como força contrária a qualquer tentativa de rompimento do isolamento estabelecido pelo recalque a um conjunto de representações. Ou seja, sempre que o trabalho de análise se aproxima de uma representação recalcada, a resistência se manifesta, tentando impedir esse trabalho, como obstáculo à rememoração” (VENTURA, 2009).

A **resistência** é a força psíquica que quer manter o *status quo*, impedindo o acesso aos conteúdos reprimidos e, assim, mantendo os sintomas derivados. Para a resistência, é melhor não enfrentar essas causas. Para a análise, é preciso enfrentá-las, como condição para a superação dos sintomas. Então, costuma-se dizer que o avanço do tratamento psicanalítico é um constante trabalho de superação de resistências.

Importante: *resistência, transferência e contratransferência* são três das mais importantes dinâmicas para se entender a psicanálise no *setting* analítico (isto é, a interação clínica entre analista e analisando). Em nosso Curso, iremos ainda por diversas vezes retomar e exemplificar esses importantes processos psicanalíticos.

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- Artigo: [Resistência e Transferência em Psicanálise](#)
- Artigo: [O que é Transferência para a Psicanálise?](#)

2.4. Complexo de Édipo e Sexualidade Infantil

Ainda considerando seu trabalho com as pacientes histéricas, Freud pôde compreender a importância da **sexualidade infantil** no processo de formação da estrutura psíquica, sobretudo, nas afecções neuróticas, como era o caso das histéricas.

Através dos relatos dessas pacientes, Freud acreditava que todas elas haviam sofrido algum tipo de abuso sexual na infância (**teoria do trauma – sedução infantil**). Contudo, passados os anos e suas reflexões, Freud pôde compreender que os relatos dessas pacientes não passavam de fantasias, ou seja, produções inconscientes para que a mente pudesse organizar (dar sentido) aos conteúdos relativos às fantasias incestuosas.

Em outras palavras, essas pacientes teriam desejos sexuais pelos seus pais, na infância. Mas, como este desejo é moralmente ilegítimo (incestuoso),

precisava ser reprimido. Então, em vez de conviverem com a culpa pelo desejo, Freud considerava que as pacientes colocavam-se como lugar de vítimas de abusos na maior parte das vezes irrealis.

Importante: por óbvio, há casos de abusos sexuais reais cometidos por pais contra filhos(as). A vida em sociedade não deve aceitar este tipo de abuso; há mecanismos legais que devem ser acionados nesses casos, em especial o Conselho Tutelar. Assim colocado, há que se ressaltar que, na obra freudiana, especificamente às pacientes que ele atendeu, prevaleceu a ideia de que muitos desses relatos seriam produções fantasiosas.

Uma das grandes contribuições da psicanálise é entender como a mente é capaz de criar uma “realidade”, tão real como se fosse de fato vivida. Nesse sentido, a psicanálise questiona a tradição filosófica que entendia o ser humano puramente como indivíduo (não dividido) e racional (consciente). Para Freud, o ser humano é muito mais do que isso:

- o ser humano é **dividido** (as instâncias do aparelho psíquico sugere a existência de três “eus”: ego, id e superego);
- o ser humano tem uma enorme porção **inconsciente**, isto é, seu aspecto racional não é integralmente “senhor” de uma pessoa.

É nesse momento que a **fantasia** ocupa um espaço importante na etiologia das neuroses histéricas (etiologia: estudo das origens das doenças). Ou seja, a fantasia assume o lugar do que antes era dito como evento traumático (o abuso sexual).

Sendo assim, há que levarmos em consideração, agora (a partir de 1897), não mais a **teoria do trauma**, mas sim a **realidade psíquica** (o que foi vivenciado como experiência subjetiva), que tem sua origem nas experiências dentro do desenvolvimento sexual infantil. A realidade psíquica era “real”, mesmo quando fantasiosa, pois afetava *realmente* a psique do paciente. Independente se fosse verdadeira ou fantasiosa, esta realidade psíquica era o material ao qual o analista tinha acesso, era, assim, uma *verdade*.

Convém ressaltar que a temática edipiana, da libido e da teoria freudiana da sexualidade merecerão módulos específicos, dentro de nosso Curso de Formação.

Em meio a essas novas descobertas e entendimentos de Freud, tanto de seus casos com as histéricas, como em seu período de auto-análise (1895-1899), Freud, em um sonho que tivera com sua filha Mathilde, constataria que “(...) *certamente é o pai o promotor da neurose*” (CARTAS A FLIESS, SBI). Ou seja, a ideia de que há, de fato, um desejo (inconsciente) que acomete sua filha, e mostrava os sentimentos mais ternos pelo pai. Surgia o esboço de outro conceito fundamental ao entendimento psicanalítico freudiano, o **complexo de Édipo**.

“Encontrei em mim, como em toda parte, sentimentos de amor por minha mãe e de ciúme em relação a meu pai, sentimentos que são, creio eu, comuns a todas as crianças pequenas, mesmo quando não aparecem tão precocemente como naquelas que foram tornadas histéricas... Se for assim mesmo, compreende-se, apesar de todas as objeções racionais contra a ideia de uma fatalidade inexorável, o efeito arrebatador do Édipo rei.” (CARTAS A FLIESS, SBI)

2.4 - Complexo de Édipo e Sexualidade

- Abusos e amores da infância
- A constituição superegoica
- Superego arcaico e superego edipiano
- A sedução infantil e as fantasias
- O amor e o ódio
- A fase fálica

REVISÃO MÓDULO 02

2.4 - Complexo de Édipo e Sexualidade

- A realidade psíquica como forma de viver
- Os desejos edipianos
- O ciúme e a inveja do pênis
- Édipo nos meninos
- Édipo nas meninas

REVISÃO MÓDULO 02

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- Artigo: [O Complexo de Édipo](#)

INDICAÇÕES DE LIVROS E CAPÍTULOS (OPCIONAIS):**2.1 - Estudos sobre histeria (1893) – VOLUME II**

Ler apenas os capítulos:

- Caso 5 - Srta. Elisabeth Von R. (págs. 102 a 134)
- A psicoterapia da histeria (págs. 181 a 217).

[Clique aqui para ler](#) ou acesse <http://bit.ly/2slAAnV>

2.2 - Primeiras publicações psicanalíticas (1893-1899) – VOLUME III

Ler apenas o capítulo:

- As Neuropsicoses de defesa (1894) (págs. 24 a 34).

[Clique aqui para ler](#) ou acesse <http://bit.ly/2EfaGb7>

Alguns links ou encurtadores de links podem deixar de funcionar (por causas externas ao Instituto). Se isso ocorrer, procure por estes materiais nos seus livros impressos ou digitais (PDFs), conforme indicações de livros, capítulos e páginas que apresentamos nas indicações.

3. A interpretação dos sonhos e a constituição do aparelho psíquico

Chegamos à virada do século. E a esse novo momento histórico, Freud pretendia entrar para a história. Em seu célebre livro “**A interpretação dos sonhos**”, pronto em 1899, mas publicado em 1900, o autor sintetiza seus achados mais preciosos em meio à clínica e à teorização ao qual mergulhara desde seu contato com a hipnose.

Sem dúvidas, trata-se de um livro corajoso e audacioso, tal qual a proposta psicanalítica para a época. Esse compilado, conforme aponta Wollheim (1971, p.72), *“além de ser o que o seu título indica, também é uma obra de confissão, na medida em que Freud confiou às suas páginas muitas das descobertas e conclusões de sua auto-análise.”*

Marcado o fim desse período de “auto-descobertas”, é dada a formulação de um constructo teórico que vai predizer todo o manejo clínico calcado, no que chamamos, de **primeira tópica freudiana**: o modelo topográfico de funcionamento da mente.

Ao longo desse capítulo, compreenderemos o papel e a importância dos sonhos nesse processo psicanalítico; a consolidação de conceitos fundamentais para o entendimento da psicanálise até então, além de

compreender as psicopatologias determinadas para além do conceito da medicina.

3 - A Intepretação dos Sonhos

- Publicação em 1900
- A constituição do aparelho psíquico
- A consolidação dos contextos psicanalíticos
- Fonte de conhecimento sobre os desejos inconscientes

REVISÃO MÓDULO 02



3.1 O livro do século e o conceito psicanalítico dos sonhos

“O sonho é o guardião do sono” (FREUD, 1900).

“**A interpretação dos sonhos**” (1900) ocupa dois volumes (vol. III e IV) das obras completas de Freud. Sua extensão vai além das inúmeras páginas dedicadas à compreensão desse fenômeno. O ponto de vista científico, a preocupação em teorizar seus achados e pensamentos, além das inúmeras cartas endereçadas a Fliess, fazem dessa obra um verdadeiro achado à humanidade, uma contribuição valiosa para conhecermos o sujeito, o simbólico, a clínica e a cultura.

De maneira sucinta, e introdutória, podemos pensar os **sonhos** como sendo “(...) *a estrada real para um conhecimento das atividades inconscientes da mente*” (WOLLHEIM, 1971, p. 72). Outros enunciados defenderão a ideia de que o *sonho seria um caminho satisfatório para a realização de um desejo* que se encontra reprimido a nível inconsciente e, por algum motivo, não é/pode ser acessado pelo consciente.

Essas constatações, entre outras oriundas dos seus estudos, puderam ser consolidadas graças ao estabelecimento de uma construção (do sonho) proveniente de traços mnêmicos (lembranças/memórias desde a infância), e de perturbações reminiscentes vivenciadas durante a vigília (quando estamos acordados).

O entendimento sobre a concepção dos sonhos como parte do funcionamento, dito “normal” da mente, é, ao mesmo tempo, compreendida como expressão patológica, haja vista os achados, dentro do trabalho com as histéricas, entre as neuroses e a estrutura dos sonhos. Isso garante a postulação de Freud sobre os sonhos como sendo “*uma via régia para chegar ao inconsciente*”. (ZIMERMAN, 1999).

Com isso é possível buscar o entendimento dos sonhos tanto do ponto de vista de sua **formação** (como se originam?), como de suas **funções** (para que servem?).

Os sonhos são formados por elaborações a partir de **estímulos sensoriais provenientes tanto do meio interno (psíquico) como do meio externo**, por acontecimentos vividos em vigília e conteúdos reprimidos a nível inconsciente. Portanto, experiências vivenciadas em vigília e conteúdos

reprimidos no inconsciente podem ser materiais que se mesclam na formação dos sonhos.

3.1 - O Livro do Século

"Os sonhos são formados por elaborações a partir de estímulos sensoriais provenientes tanto do meio interno (psíquico) como do meio externo".

REVISÃO MÓDULO 02



Os sonhos podem ser compreendidos como sendo **uma estrada (ou "via régia") ao inconsciente**. São compostos de conteúdos recalcados no inconsciente e de "restos diurnos" (lembranças do estado de vigília), além de permitir acesso não literal aos elementos inconscientes.

Assim, é equivocado buscar uma interpretação literal do sonho, a partir do mundo consciente (pensamento, percepção e raciocínio) de quem sonha.

Para Freud a **formação dos sonhos** se estabelecerá por três vieses principais:

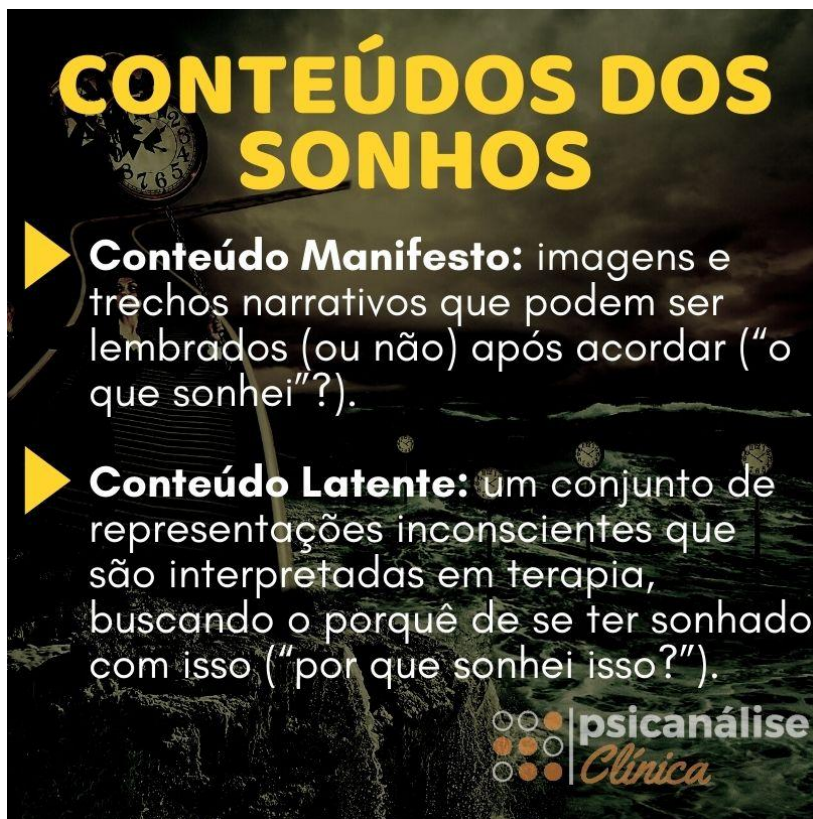
- **Estímulos sensoriais:** influência de perturbações tanto do meio externo (barulhos, luz...), como do meio interno (sensações respiratórias ou urinárias...).

- **Restos diurnos:** episódios vivenciados em vigília (estado acordado), nos quais, por qualquer motivação, mostraram-se significativos à subjetividade do indivíduo.
- **Conteúdos inconscientes reprimidos:** pensamentos, sentimentos e desejos que se mantêm imersos no inconsciente.

Nesse sentido, e para que haja um entendimento sobre a dinâmica dos sonhos, é preciso compreender que eles possuem uma forma de **funcionamento, organização e linguagem própria**, e que vão caracterizar seus meios e maneiras de se manifestarem.

Para isso, Freud concebe dois conceitos pelos quais os pensamentos oníricos (conteúdos inconscientes) transitariam: o **conteúdo manifesto** do sonho e o **conteúdo latente** do sonho.

- **Conteúdo manifesto:** caracterizado pelas imagens que aparecem no consciente durante o sono, e que podem, ou não, serem lembradas após o despertar; e
- **Conteúdo latente:** um conjunto de correspondentes (pensamentos, sentimentos, repressão e angústias) que se encontram reprimidos pelo inconsciente, graças ao censor onírico, e, portanto, ficam inacessíveis de maneira direta ao inconsciente.



Desse modo, para que ocorra, o que Freud chamou de **trabalho do sonho**, algumas “defesas” são mobilizadas para que os pensamentos oníricos possam, de maneira indireta, se manifestar a nível consciente. Esses dispositivos que formam os sonhos podem alcançar os conteúdos reprimidos no inconsciente, exatamente porque suspendem esses mecanismos dos sonhos “bloqueiam” as barreiras de repressão. Mas, ao mesmo tempo, esses mecanismos são arredios a interpretações literais: é preciso interpretar o sentido figurado por trás de um sonho.

Dentre tais mecanismos que formam os sonhos, destacamos:

- **Deslocamento:** por meio de uma cadeia associativa, é como se os pensamentos oníricos se “deslizassem” entre uma imagem e outra, de modo a substituir o significado desses conteúdos. O significado original

de “casa” pode significar “proteção”, “mãe” ou qualquer outro conteúdo (não há uma rigidez interpretativa), caberá ao processo analítico interpretar.

- **Condensação:** os representantes dos pensamentos oníricos são, por assim dizer, condensados, unidos e/ou fusionados, de modo a impedir qualquer correspondência clara e nítida entre os conteúdos manifestos e latentes. Ou seja, em uma mesma imagem, ou partes dela, (pessoas, lugares, coisas) e/ou manifestação, podem ocorrer elementos diferentes que se sobrepõem, dificultando o trabalho interpretativo.
- **Simbolização/Representação:** determinadas imagens já conhecidas apresentam uma determinada representação no contexto do sonho. Por exemplo, uma serpente poderia representar o poder fálico do pênis, ou ainda ser a representação de uma pessoa traiçoeira, tal qual uma cobra. Por tempos, Freud pensou que essa linguagem poderia ser universal, mostrando a mesma simbolização a qualquer pessoa; porém, logo desacredita desse pensamento, pelas experiências vivenciadas em sua clínica. Ou seja, cada imagem recebe sua própria representação dentro do universo particular do paciente.

Desse modo, é possível pensar uma forma de linguagem do sonho, desde sua formação até sua forma de representação na mente do indivíduo, e a representatividade em sua vida psíquica.

É graças à **elaboração onírica secundária**, que age como uma espécie de “disfarce” desse conteúdo inconsciente, que o conteúdo manifesto toma sua

forma, como uma **formação de compromisso** entre as pulsões do id as defesas do ego, para que se emerja ao consciente com uma forma tolerável ao sujeito.

Isto é, o sonho alcança conteúdos do id (inconscientes), mas “entrega” este conteúdo de forma modificada, para não derrubar as defesas do ego (lembre-se: o ego tem mecanismos de defesa para os quais é mais conveniente reprimir eventos insuportáveis).

Em síntese, para Freud, os sonhos seriam **um caminho para acessar o inconsciente**, tal qual ele assume enquanto prática clínica. Mas, seria um caminho tortuoso, que demanda uma interpretação do analista. Desse modo, os sonhos seriam uma construção da mente, a partir de medos, traumas, angústias, frustrações e desejos do indivíduo que, por algum motivo, não conseguem acessar a via consciente.

Costuma-se dizer que a Psicanálise desde a obra de maturidade de Freud até nossos dias baseia-se em dois métodos:

- A **livre associação**;
- A **interpretação dos sonhos**.

Entretanto, arriscamo-nos dizer que se trata de **um único método: a livre associação**, já que a interpretação dos sonhos para a psicanálise tem sua efetividade quanto também posta no *setting* analítico. Assim, o sonho é interpretado durante as sessões da análise (e as sessões de análise utilizam-se da livre associação).

Os conteúdos dos sonhos acabam por se manifestar de maneira simbólica, por meio de três mecanismos principais:

- a condensação,
- o deslocamento e
- a representação/simbolização.

Nessas transformações oníricas, os **conteúdos latentes** (ou seja, aqueles pertencentes à esfera do inconsciente) se mostrariam por meio de **conteúdos manifestos** (aqueles que fazem parte da “história” sonhada), sendo assim, uma maneira do consciente poder visualizar questões profundas e que não estão acessíveis, sejam elas um caminho satisfatório para a realização de um desejo reprimido, ou ainda a apresentação, como forma de defesa, de angústias que não podem ser reveladas.

Então, na psicanálise, o analisando (“sonhador”, aquele que sonha) poderá (dentre outros materiais) reportar ao seu psicanalista o **conteúdo manifesto** dos sonhos; isto é, as histórias (narrativas) lembradas dos sonhos. O psicanalista ajudará o analisando (paciente) no processo de interpretar possíveis **conteúdos latentes**, ou seja, uma compreensão potencialmente inconsciente por trás do que foi narrado e condizente com outros processos psíquicos da vida “em vigília” do paciente.

3.1 - O Livro do Século

- “O sonho é o guardião do sono”
- Estruturação da psicanálise
- Percepção dos desejos que se manifestam durante o sono (não controle)
- O princípio do prazer
- Um caminho para o inconsciente

REVISÃO MÓDULO 02

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- **Artigo:** [Por que sonhamos? Os mecanismos de formação dos sonhos](#)
- **Artigo:** [A interpretação do sonhos: breve resumo do livro](#)

3.2. O aparelho psíquico – primeiros passos

Antes de ingressarmos na determinação dos componentes que constituem esse modelo idealizado por Freud em sua Primeira Tópica, devemos retomar as origens das concepções freudianas sobre a **etiologia da**

psicopatologia (ou seja, o estudo das origens dos transtornos psíquicos), do mesmo modo que aparece em seu texto “**Comunicação preliminar**”, de 1893.

Havia um entendimento sobre o que Freud determinou **teoria do trauma**, de que, durante a infância, o indivíduo sofrera abuso sexual propriamente dito e que essa experiência havia ficado reprimida no inconsciente, retornando, na vida adulta, na forma de sintoma.

Contudo, a experiência de Freud com as histéricas indicou que a correspondência sintomática não estava vinculada necessariamente à ação traumática propriamente dita, mas sim às fantasias inconscientes, que distorciam a versão real dos fatos.

Desse modo, uma vez que a teoria do trauma não era capaz de “*explicar a complexidade que de forma crescente a psicanálise vinha enfrentando*” (ZIMERMAN, 1999, p. 81), Freud postulou dois princípios fundamentais e que orientariam a psicanálise a partir de então:

- a **multideterminação** (a ideia de que muitos podem ser os fatores de explicação que influenciavam o desenvolvimento psíquico) e
- a existência do **inconsciente**.

Desde então, Freud passou a se debruçar no desenvolvimento de modelos, teorias e concepções metapsicológicas (que fundariam conceitos de base da psicanálise, como sendo compatível com um entendimento científico, ou seja, que permitiria o desenvolvimento de um importante campo de investigações.)

Metapsicologia ou metapsicanálise: é quando a psicologia ou a psicanálise fala de si mesma. Por exemplo, o conceito de **transferência** é uma noção metapsicológica (ou metapsicanalítica), porque é a psicologia/psicanálise falando de seus próprios métodos.

Sendo assim, por meio de metáforas que permitissem a abstração a partir de imagens concretas, e por construção de um conjunto de hipóteses, cientificamente promissoras, graças ao empirismo clínico, Freud nos apresenta um modelo de aparelho psíquico baseado na concepção da **energia psíquica** e sua relação com os mecanismos mentais, sobretudo do ponto de vista econômico. “Econômico”, aqui, não tem conotação financeira ou monetária, mas sim o sentido de utilização ou otimização de recursos disponíveis (no caso, a forma de utilização da energia psíquica ou mental).

Desse modo, Freud nos apresenta o conceito de **pulsão**, como sendo *“representante psíquico das excitações provenientes do interior do corpo e que chegam ao psiquismo”* (ZIMERMAN, 1999, p.82). Ou seja, trata-se de um elemento quantitativo da economia psíquica, que podemos, de certo modo, descrevê-la como correlata a uma energia/força que precisa ser ligada a um representante (um afeto ou a uma ideia), para que possa se manifestar. A essa vinculação da energia pulsional ao seu representante psíquico, Freud deu o nome de **catexia**.

Freud, nesse primeiro momento, divide o conceito de pulsões em duas categorias: as **pulsões de auto-conservação** e as **pulsões sexuais**.

- As **pulsões de auto-conservação** se constituiriam na busca pela realização e satisfação das necessidades essenciais e exigências

provenientes da sua estrutura somatopsíquica (entendimento de corpo (soma) e psique). São as pulsões para “manter-se vivo”. Desse modo, o bebê, por exemplo, seria regido basicamente por essas pulsões, na busca por calor, amparo, alimentos etc.

- As **pulsões sexuais** são identificadas por Freud como sendo todo o prazer corporal não derivado dessas necessidades essenciais acima citadas; mas sim, de estímulos provenientes das **zonas erógenas**, principalmente aquelas ligadas à boca, ao ânus, ao aparelho genital urinário, entre outros. A essas pulsões sexuais, Freud deu o nome de **libido**.

Nesse ponto, é importante ressaltar que Freud distingue o conceito de **instinto** e **pulsão**. Para o autor,

- o **instinto** é algo hereditariamente determinado, apresenta um cunho biológico, e possui um objeto de representação específico, a exemplo de quando precisamos nos alimentar; a fome seria, portanto, um objeto de satisfação a ser atendido, de maneira instintiva e necessária;
- a **pulsão**, por sua vez, é o investimento energético em determinado objeto (ideia ou afeto) que é fruto de um desejo; daí então a diferenciação, quando comparada ao instinto, pois **não há um objeto definido**, e nem podemos assumi-lo como sendo parte do consciente ou do inconsciente, uma vez que a força pulsional transita por essas instâncias, vinculando-se ao representante à medida que a realização de um desejo se faz iminente.

O entendimento do que Freud chamou de **teoria das pulsões** é necessário para compreendermos a dinâmica psíquica dentro da sua possibilidade de mobilização energética (pulsional) na direção da descarga ou satisfação de um desejo. Em nosso Curso, teremos um módulo dedicado ao aprofundamento da discussão sobre pulsões, libido e sexualidade.

Importante: em muitas partes das obras psicanalíticas e desta apostila, fala-se em “as histéricas”, com se as pessoas acometidas fosse apenas mulheres. Nos primórdios da psicanálise, entendia-se a *histeria* como essencialmente feminina, relacionada ao **útero** (útero = *hyster*, em grego, origem do termo *histeria*).

Isso se devia em grande medida à repressão principalmente de natureza sexual contra as mulheres, repressão que tinha uma manifestação sintomática entendida como *histérica*. Entretanto, mais recentemente, fala-se em “pessoas histéricas” (homens histéricos e mulheres histéricas). Abaixo, trazemos um link para um artigo em que este debate é aprofundado.

3.2 - O aparelho psíquico

- Teoria do Trauma - o que aconteceu na infância continua a afetar na fase adulta
- Multideterminação e o inconsciente
- Pulsões de autoconservação e sexuais
- Instinto x Pulsão

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- Artigo: [Pulsões sexuais e Libido segundo Freud](#)
- Artigo: [Histérica ou Histérico: qual o gênero da histeria?](#)

3.3. O aparelho psíquico – a descrição do modelo topográfico

Uma vez colocados esses conceitos e ideias primárias, e traçado esse caminho sobre a dinâmica e funcionamento da mente, Freud estrutura, mais formalmente, a ideia de **aparelho psíquico** no, famoso, capítulo VII do livro “**A interpretação dos sonhos**” (1900). Portanto, apresenta a ideia de um **modelo topográfico** do aparelho psíquico e, para tanto, lança mão e organiza três sistemas (ou instâncias) sobre os quais esse aparelho se estabeleceria: **o inconsciente (ICs), o pré-consciente (PCs) e o consciente (Cs)**.

A ideia de modelo topográfico vem de “*topos*”, que em grego significa “lugar”, daí então a explicação de que esses sistemas ocupariam lugares e funções bem específicas, determinando a dinâmica do funcionamento psíquico (ZIMERMAN, 1999). Nesse sentido, a preocupação do Freud não está em um

entendimento de lugar como sendo um local anatômico, mas sim uma teoria conceitual, um lugar virtual, que estaria voltada ao entendimento da dinâmica.

Sendo assim, Freud pensa nessas instâncias (Ics, Pcs, Cs) como uma forma de organizar e estruturar o funcionamento do aparelho psíquico, assumindo-se um lugar (um papel) para cada sistema e suas relações entre si, dentro da dinâmica da psique. Ou seja, cada uma com determinada função e características dentro do aparelho psíquico, como veremos a seguir.

3.3 - O modelo topográfico

- O inconsciente (Ics)
 - Ambivalência simultânea
 - Não existe a negação
 - Não há temporalidade
- Pré-Consciente (Pcs)
- Consciente (Cs)

REVISÃO MÓDULO 02

3.3 - O modelo topográfico

- Processo primário x processo secundário
- Princípio do Prazer x Princípio da Realidade

**"Eu fiz isso, mas é algo inconsciente!
Será?"**

REVISÃO MÓDULO 02



3.3.1. O inconsciente (Ics)

Tema central e revolucionário da teoria freudiana, essa instância psíquica é notoriamente o ponto nodal da dinâmica do aparelho psíquico. Possui uma forma de funcionamento regida por leis e meios, muito específica e que foge aos entendimentos provenientes da racionalização consciente.

É, por assim dizer, a parte mais arcaica do aparelho psíquico, constituídas de traços mnêmicos (lembranças primitivas) que, também, responde pelas fantasias arcaicas. Ou seja, é nesse sistema que se inscrevem experiências e sensações da infância, provenientes da relação com o mundo por meio dos órgãos do sentido, e que são nomeadas como **“representação das coisas”**, inscrições subjetivas de experiências infantis que não poderiam ser nominadas.

No Ics, também, se encontram representantes pulsionais (ideias ou afetos) fortemente catexizados (investidos de energia) e que buscam a

descarga pulsional incessantemente, uma vez que o inconsciente é regido pelo **princípio do prazer** (trata-se de uma dinâmica que, em virtude do aumento da tensão pulsional – e que gera desprazer –, há a necessidade da descarga energética como forma de encontrar satisfação/prazer).

Como características fundamentais, o inconsciente não apresenta uma “lógica racional”, desse modo tempo, espaço e causalidade não existem. Talvez esse conceito seja o mais difícil de compreender, uma vez que para essa forma de funcionamento inconsciente, existem apenas:

- **afirmações:** não há incertezas ou dúvidas;
- **ambivalência:** representação de amor e ódio ao mesmo simultaneamente;
- **atemporalidade:** não segue a ordem cronológica da vida.

O inconsciente opera segundo as leis dos **processos primários**, ou seja, neles a energia psíquica transita livremente pelos sistemas, passando de uma representação a outra. É nesse ponto que a interpretação dos sonhos tem o papel fundamental no entendimento do aparelho psíquico freudiano, pois a “comunicação” nos sonhos se daria graças ao processo primário, e seus mecanismos (condensação, deslocamento e representação) constituiriam a elaboração onírica presente nos conteúdos latentes.

Desse modo, os processos secundários sugeridos por Freud irão constituir a comunicação do sistema (‘pré-consciente’-consciente), como veremos a seguir.

3.3.2. O pré-consciente (Pcs)

Essa instância psíquica, em esboços de Freud, pode ser considerada uma “barreira de contato” entre Cs e Ics, servindo como uma espécie de filtro para que determinados conteúdos possam (ou não) emergirem a nível consciente.

Para muitos autores, o inconsciente é inacessível (por não ter uma linguagem capturável pelo lado racional), só podemos supor elementos do inconsciente a partir de elementos indiretos (como sonhos, chistes, atos falhos etc., que veremos no decorrer do curso) ou através dos sintomas e transtornos que sugerem haver fatos inconscientes na origem. É o pré-consciente que permite que alguns dos elementos inconscientes sejam trazidos ao consciente, exatamente pelo fato de o Pcs ser a fronteira entre Ics e Cs.

Desse modo, os conteúdos presentes no Pcs estão disponíveis ao acesso do Cs, ou seja, são suscetíveis de tornarem-se conscientes. É nessa instância que a linguagem se estrutura e, dessa forma, é capaz de conter a “**representação da palavra**”, *“que consiste num conjunto de inscrições mnêmicas de palavras oriundas e de como foram significadas pela criança”* (ZIMERMAN, 1999).

Note que “representação da coisa” e “representação da palavra” são conceitos diferentes:

- a **representação da coisa** é uma experiência inominável, e via de regra, é um componente inconsciente;

- a **representação da palavra** traz uma significação dentro da lembrança infantil; ou seja, quando algo é elaborado na forma de palavra, é possível de ter uma significação pré-consciente e consciente.

Nesse sentido, considerando o valor da economia e dinâmica energética, *“(...) a energia começa por estar “ligada” antes de se escoar de forma controlada; a satisfação é adiada, permitindo assim experiências mentais que põem à prova os diferentes caminhos possíveis de satisfação.”* (LAPLANCHE & PONTALIS, 1996, p. 371)

Segundo ARNAO (2008):

“As representações de coisa (o propriamente psíquico, o conteúdo do inconsciente) são representações, porém seu conteúdo não é referencial no sentido de remeter a uma única coisa. (...) Se uma representação é algo que está no lugar de outra coisa, e por conseguinte é intencional e, ao mesmo tempo tanto as representações de palavra, que não remetem a uma única coisa, nem as representações de coisa a um único traço mnêmico ou objeto indiferente à maneira de objetivo, então o próprio conceito de intencionalidade se torna mais complexo e, com ele, o de significado.”

Ou seja, a representação da coisa é típica da dinâmica do inconsciente: não se prende a uma explicação lógica e única, é uma representação volátil, que não pode ser dita ou racionalizada. É uma representação que tem uma existência, mas que não pode ser convertida em palavras exatas. Por exemplo, uma pulsão ou um trauma inconsciente não se fixa em um objetivo específico.

Já a representação de palavra pode ser explicada, porque ela se fixa a um objeto específico (o desejo que temos de uma coisa ou de uma pessoa) e, por isso, já estaria nos níveis Pcs e Cs.

3.3.3. O consciente (Cs)

Pensando na questão topográfica do modelo, o consciente se diferencia do inconsciente, pela forma como é operado através de seus códigos e leis. À instância consciente é atribuído tudo aquilo que está disponível imediatamente à mente.

O consciente é a percepção que pode ser posta em palavras do sujeito sobre o que ele é, foi ou quer ser; sobre como ele está, como as coisas são ou funcionam etc. É a instância que normalmente associamos à razão e ao racional, à percepção de espaço e tempo.

Mas, como vimos, não é imune a erros: aquilo que acreditamos que somos e que escolhemos podem ser, na verdade, constructos inconscientes que nos formaram (a influência familiar e social a que fomos submetidos). Esta é uma das maiores contribuições de Freud: desmontar a crença de que o “indivíduo” é somente consciência, desmontar a crença de que o racional é senhor de si.

Nesse sentido, podemos pensar que a formação consciente se daria pela junção da “representação da coisa” e da “representação da palavra”, ou seja, há um investimento energético em determinado objeto e, então, seu

escoamento adequado para a satisfação. Ou seja, a energia psíquica não está caminhando livremente pelas representações somente da coisa, ela está, agora, vinculada a uma representação específica, uma referência que une coisa e palavra e, portanto, permite a comunicação desses conteúdos. A esse modo de funcionamento dos sistemas Pcs-Cs damos o nome de **processos secundários**.

Então, assim como o ICs possui seus processos primários, o consciente e o pré-consciente possuem processos secundários, na sua forma de comunicação por meio da organização dessas representações.

Associe:

Inconsciente	Pré-consciente	Consciente
Processos primários	Processos secundários	Processos secundários
Representação de coisa	Representação de palavra e de coisa	Representação de palavra e de coisa
Funcionamento atemporal, ambivalente e composto só de afirmações	Fronteira entre lcs e Cs	Linguagem racional, temporal e espacial

Com os processos secundários, é possível estabelecer linhas de raciocínios, apresentar percepções e ponderações, fazendo com que seja respeitado **o princípio da realidade** (mecanismo capaz de avaliar a satisfação, retardando e/ou inibindo a descarga pulsional e, em determinadas ocasiões, tolerando o desprazer).

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- **Artigo:** [Freud e o Inconsciente: um guia](#)
- **Artigo:** [Inconsciente, Pré-Consciente e Consciente](#)
- **Artigo:** [Princípio do Prazer e Princípio da Realidade](#)

3.3.4. A dinâmica das instâncias

Uma vez compreendida a estrutura topográfica, faz-se necessário que busquemos compreender a dinâmica que envolve essas três instâncias psíquicas (Ics, Pcs e Cs), como se dá a relação entre elas, de que maneira as pulsões transitam por esses “lugares”, e quais as repercussões nas formas de funcionamento psíquico (e relacional) do indivíduo.

E, para iniciarmos tais discussões, abordaremos um conceito que Freud atribuiu, junto à estrutura de seu modelo de aparelho psíquico topográfico, como sendo o **recalcamento**. Situado, de maneira ilustrativa, nos limites entre o inconsciente e o pré-consciente, a *barreira* do recalque seria responsável pelo impedimento ao sistema (Pcs-Cs), de conteúdos que seriam angustiantes ou intoleráveis à psique, provenientes de experiências infantis.

Lembre-se: o Ics não se deixa conhecer de maneira *direta*. o Ics é inacessível à nossa linguagem racional. Para termos consciência de algo Ics, seria preciso que isso saísse do Ics e transitasse pelo Pcs e, depois, pelo Cs. Ocorre que, para impedir que o Ics venha à tona, o mecanismo de recalcamento seria uma barreira entre o Pcs e o Cs.

Também nomeado como **repressão**, esse mecanismo é, digamos, uma primeira linha de defesa a esses conteúdos insuportáveis e que, sem eles, o indivíduo não poderia vir a se constituir (como Ser) de maneira satisfatória. Desse modo, esses conteúdos angustiantes (representação + seu afeto correspondente) estariam submetidos ao nível inconsciente e, portanto,

inacessíveis às demais instâncias, graças à censura responsável pelo recalçamento.

Contudo, essa censura, ou barreira, pode se enfraquecer ou esse conteúdo reprimido estar tão investido de energia pulsional, que o afeto se desprende de sua representação e, então, é capaz de transitar entre as instâncias (ganha acesso ao consciente) na tentativa de buscar outra representação para se vincular. A esse movimento de carga pulsional Freud denominou o **retorno do recaiado** (ou reprimido).

Em resumo, algo insuportável foi recaiado. Não há acesso consciente pleno a esse conteúdo, mas representações significativas (carregadas de energia pulsional) podem escapar e ganhar a forma de sintoma. Esse é o retorno do que foi recaiado, um sinal de que o recaiado não foi “resolvido”.

Para Freud, essa falha no mecanismo de recalçamento, que permitiu a liberação da pulsão sexual, estaria na etiologia (origem) das neuroses. Ou seja, esse **afeto** (energia libidinal) que escapou ao recalçamento (retorno do recaiado) emerge ao nível consciente buscando descarga, na forma de sintomas físicos, ansiedades, medos, hábitos excessivos, entre outros que vão variar de acordo com a categoria neurótica (histeria, obsessão ou fobias).

HISTERIA, FOBIA

E OBSESSÃO

psicanálise
Clínica

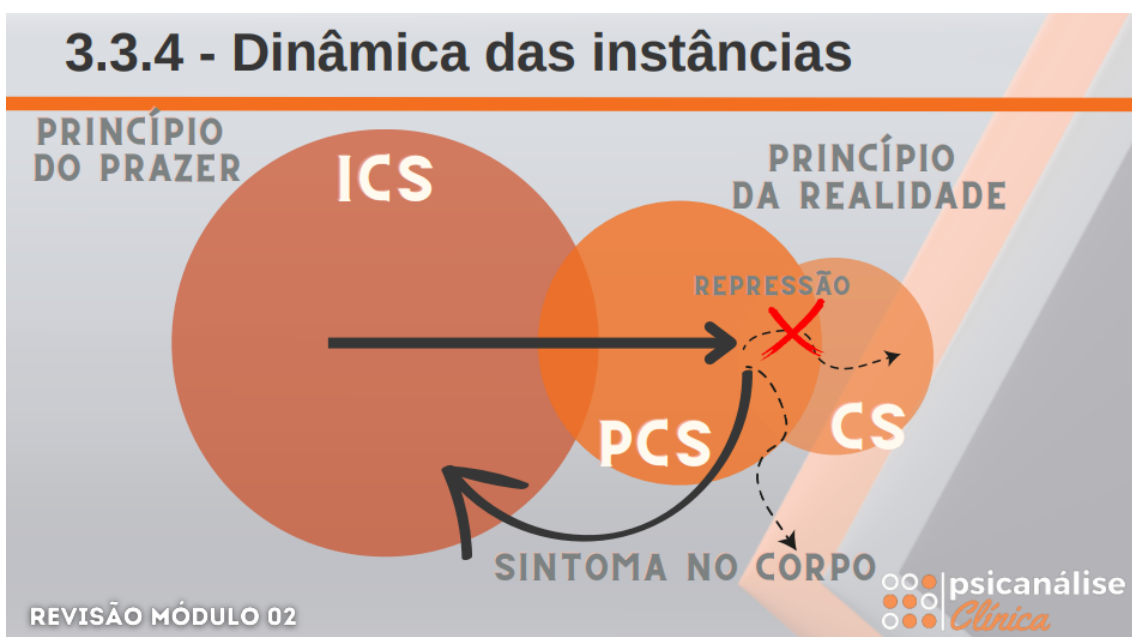
- ▶ As fobias seriam essencialmente **psiconeuroses**, relacionadas a eventos da infância que encontram **substitutos fóbicos**.
- ▶ Um mecanismo comum à histeria, fobia e obsessão é a **incapacidade de elaboração frente a uma experiência ou sentimento aflitivo**.
- ▶ Isso faz com que uma representação "esquecida" (recalcada) seja elaborada psiquicamente como um medo, um "tique", uma compulsão...

Um exemplo bem representativo desse mecanismo estaria na **conversão histérica** (que será detalhada melhor no módulo 3). Na gênese dos estudos psicanalíticos as histéricas (mulheres que manifestavam sintomas físicos sem representantes fisiológicos que sustentassem ou justificassem esses sintomas), era possível verificar casos de cegueira temporária, ou seja, mesmo com o aparato óptico intacto e com os funcionamentos normais, a pessoa não conseguia enxergar, o que, para Freud, só poderia ter base psíquica.

Assim, cabe o entendimento, quando realizado o tratamento analítico, que por alguma experiência angustiante visualizada (por isso a representação dos olhos) ou contextualmente fantasiada há um registro inconsciente dessa **percepção** (representação + afeto) que é reprimida pela censura. Esse afeto (energia libidinal) vinculado à impossibilidade de realização de um desejo

(também libidinal) e altamente investido energeticamente buscaria um caminho para satisfação (uma vinculação a um representante) que, no caso das histéricas, esse representante seria o corpo.

E, nesse exemplo, e de forma puramente didática e interpretativa, poderíamos associar à **dificuldade de olhar**, uma vez que esse afeto, que estava reprimido, é vinculado ao sistema ocular, pois, na atualidade, a paciente tenha vivenciado uma experiência que gostaria de olhar determinada coisa (representante de seu desejo), mas, por algum motivo fora impedida (por fatores internos ou externos, resultando na impossibilidade de realização de seu desejo).



INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- Artigo: [Recalcamento e o Retorno do Recalcado](#)

3.3.5. O inconsciente e o cotidiano

Freud, nesse momento de sua trajetória, e muito mais claramente ao final das suas obras, vai tecer alguns textos sobre o como sua teoria psicanalítica é percebida no cotidiano da sociedade, seja através de uma conversa, seja pelas marcas da guerra, ou ainda, pelos esforços do Homem dentro de seu sofrimento psíquico para conseguir viver em sociedade.

Dessa forma, Freud cria dois escritos muito interessantes e que certamente reverberam, enquanto entendimento cultural, nos dias de hoje, a “**Psicopatologia da vida cotidiana**”, de 1901, e “**Chistes e sua relação com o inconsciente**”, de 1905. Falaremos bem sucintamente sobre as principais temáticas abordadas.

Em “**Psicopatologia da vida cotidiana**” (1901), livro que compõe o VI volume de suas Obras Completas, Freud nos apresenta o conceito de **ato falho**. Tal qual o sonho, o ato falho é um mecanismo que traz a expressão do inconsciente, dentro do contexto dos processos primários.

De uma maneira bem abreviada, podemos compreender esse fenômeno como sendo **um desejo que se realiza de uma maneira evidente**. Em outras palavras, poderíamos compreendê-lo como sendo um compromisso estabelecido entre uma intenção consciente e um desejo inconsciente ligado a ela. Por exemplo, quando se troca o nome de alguma pessoa em certas

ocasiões, ou quando uma palavra “some” momentaneamente da mente, ou ainda quando trocamos uma palavra por outra. Outros tantos poderiam ser citados, como errar um caminho costumeiramente realizado, o esquecimento de senhas, entre outros.

A expressão “Freud explica”, tão comentada até fora dos meios psicanalíticos, provavelmente tenha relação com a ideia freudiana de conteúdos secretos até nos fatos mais banais. É parte do método freudiano a atenção aos erros, lapsos e acasos, como sendo potenciais revelações de processos inconscientes. Isso também está presente em seus estudos dos chistes.

Em “**Chistes e a sua relação com o Inconsciente**” (1905), livro que compõe o volume VIII, Freud coloca que o chiste (ou piada) seria, também, uma expressão do inconsciente. Utilizando os mecanismos dos processos primários (condensação, deslocamento e representação), esses conteúdos estariam possibilitando a expressão de manifestações inconscientes, seja através de um duplo sentido, ou de um jogo de palavras, ou ainda por percepções de pensamento.

Nesse sentido, os chistes são uma produção social que busca a obtenção do prazer, em vias que são satisfatórias ao indivíduo e ao seu meio social. Certamente você já ouviu dizer que “toda brincadeira tem um fundo de verdade”, correto?

3.3.5 - O inconsciente no cotidiano

- Atos falhos - Psicopatologia da Vida Cotidiana (1901)
- Chistes - Chistes e sua relação com o inconsciente (1905)
- Interpretação dos sonhos (1900)
- O Recalque (1915)

REVISÃO MÓDULO 02

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- Artigo: [Resumo de “Psicopatologia da Vida Cotidiana”](#)
- Artigo: [Resumo de “Chistes e sua relação com o Inconsciente”](#)

INDICAÇÃO DE LEITURA:

2.3 - A Interpretação dos sonhos (I) (1900) - VOLUME IV

Ler apenas os capítulos:

- Capítulo II: O método de interpretação dos sonhos (págs. 76 a 92)
- Capítulo III: O sonho é a realização de um desejo (págs. 92 a 98)

[Clique aqui para ler](#) ou acesse <http://bit.ly/2Ez886X>

2.4 - A Interpretação dos sonhos (I) (1900) - VOLUME V

Ler apenas o capítulo:

- Capítulo VII: A psicologia dos processos oníricos (págs. 115 a 186)

[Clique aqui para ler](#) ou acesse <http://bit.ly/2CbWolz>

4. O segundo modelo de aparelho psíquico

“Onde houve Id (e superego), o ego deve estar”. (FREUD)

Em um salto cronológico estratégico na linha temporal da obra freudiana, vamos à década de vinte do século XX, mais precisamente em 1923, quando Freud publica **“O Ego o Id e outros trabalhos”**. Obviamente esse livro é uma consolidação dos seus anos de prática clínica e reflexões, sobretudo dos seus modelos teóricos sugeridos até então.

Essa obra, volume XIX de suas obras completas, marca a proposição de um novo modelo para o aparelho psíquico. Embora Freud entenda que seu modelo antigo possuía limitações que impeçam um entendimento mais expressivo dos achados psicanalíticos, o autor não descarta o modelo topográfico. O que Freud faz é ampliar seu entendimento sobre a dinâmica das instâncias psíquicas e, agora, propõe uma nova forma de compreensão, o **modelo estrutural do aparelho psíquico**.

Nessa chamada Segunda Tópica (ou modelo estrutural), Freud vai sugerir a formulação de um modelo não mais voltado a um entendimento de lugar virtual, mas sim de estruturas ou instâncias psíquicas, que interagem constantemente para que ocorra o funcionamento do aparelho psíquico, estamos falando do **ID, EGO e SUPEREGO**.

E, na tentativa de ilustrar a dinâmica desse novo modelo, juntamente com os correspondentes advindos da primeira tópica (Ics, Pcs e Cs), segue uma figura que é capaz de organizar essas instâncias de maneira didática:



É sempre importante revisar a imagem acima. Ela unifica as duas tópicas freudianas. Veja que:

Então, justapondo Primeira e Segunda Tópicas, temos que:

- o **Id** é TODO inconsciente.

- O **ego** é parte consciente (da lógica racional e do que estamos pensando agora, por exemplo) e parte inconsciente (dos mecanismos de defesa do ego, por ex.).
- O **superego** é parte consciente (das regras morais que estamos cientes que existem, como “não matar”) e parte inconsciente (das crenças e valores que temos e que acreditamos serem naturais, por exemplo contidos na linguagem, no discurso, na religião, na forma de vestir, na forma de diferenciar os gêneros etc.).

Em primeiro lugar, é importante perceber que a ilustração acima busca relacionar a 1a (Ics, Pcs e Cs) e 2a (ego, id, superego) tópicas. Mesmo após propor sua 2a Tópica, Freud não abandonou sua 1a Tópica. São formas complementares de propor o funcionamento do aparelho psíquico.

Por meio da figura acima, é possível compreendermos, inicialmente, como essas instâncias psíquicas estão organizadas para, na sequência, esmiuçar cada uma delas, considerando sua origem, constituição, função, entre outros.

Perceba que o **ID**, além da “maior parte” componente desse sistema, está também todo localizado no inconsciente, ou seja, seu nível psíquico permanece inacessível pelo sistema “pré-consciente-consciente”.

Observe que o **ID é somente inconsciente** (ou seja, o ID não tem partes conscientes), mas a recíproca não é verdadeira: **o inconsciente não é**

somente o ID, pois Freud considera que Ego e Superego também têm partes inconscientes.

O **SUPEREGO**, por sua vez, atravessa todo o conteúdo (Ics, Pcs, Cs), mantendo-se, em partes, imerso a nível inconsciente. O Superego tem uma pequena parte consciente, que, de maneira sucinta, podemos relacionar com as regras sociais/morais das quais temos consciência (sendo que partes dessas regras são interiorizadas inconscientemente).

De mesmo modo, o **EGO** também possui sua parte inconsciente, e tem a árdua tarefa de servir a esses “dois senhores” (ID e SUPEREGO), como forma de encontrar a satisfação dessas instâncias, um trabalho intenso e constante, na tentativa de buscar o equilíbrio dessas forças.

Dentro dessa dinâmica podemos pensar a relação dessas instâncias psíquicas como sendo parte integrante do que Freud chamou de **teoria da personalidade**. Ou seja, a forma com a qual esses sistemas se organizam no sujeito, tanto do ponto de vista estrutural como relacional, vão determinar a maneira com a qual o indivíduo vai interagir com o mundo.

Essa organização psíquica da personalidade, bem como os desdobramentos para a vida da pessoa, além das psicopatologias que compõem a subjetividade psíquica, serão exploradas com maior atenção no módulo III do nosso Curso de Formação.

Em latim, *id* traduz-se como *isso*, um pronome normalmente atribuído a objetos de natureza mais indeterminada, indeterminação esta que Freud pretendeu recuperar ao designar nossa função mental mais desconhecida.

De modo sucinto, o Id pode ser considerado como sendo constituído “*por uma espécie de reservatório de impulsos caóticos e irracionais, construtivos e destrutivos, não harmonizados entre si ou com a realidade exterior*” (VALENTE, 2002, p. 94).

Para Freud, o recém-nascido é puramente ID, ou seja, um aglomerado de impulsos (ou pulsões) desorganizados e sem direcionamento. Isso significa que, nessa fase, não há um EGO estabelecido, ele deverá ser constituído a partir das vivências e experiências subjetivas, que, a cada dia, vão confrontar a constante busca pela realização do desejo (do ID), seja pelos castigos instituídos às tentativas de satisfação, seja pela impossibilidade de realizá-lo.

Essa forma de pensamento, a construção e não a existência prévia de um EGO arcaico é o que vai, entre outras questões, diferenciar a teoria freudiana de outros autores como Melanie Klein e Winnicott, por exemplo, (discutiremos com mais detalhes nos próximos módulos).

Ainda, é importante destacar, pensando sobre as funções e funcionamento do ID, que, segundo Zimmerman (1999),

“Sob o ponto de vista *econômico*, o id é a um só tempo um reservatório e uma fonte de energia psíquica. Do ponto de vista *funcional*, ele é regido pelo princípio do prazer; logo, pelo processo primário. Do ponto de vista da *dinâmica* psíquica, ele abriga e interage com as funções do ego e com os objetos, tanto os da realidade exterior, como aqueles que, introjetados, estão

habitando o superego, com os quais quase sempre entra em conflito, porém, não raramente, o id estabelece alguma forma de aliança e conluio com o superego.” (ZIMERMAN, 1999, p. 83).

Como posto até então, o ID está totalmente imerso no inconsciente e seu condicionamento de escoamento energético (libido) está vinculado e regido pelo **princípio do prazer**. Isso significa que as pulsões do ID vão buscar sua satisfação a qualquer custo, sem a consideração da racionalidade, moralidade ou sociabilidade. É, portanto, uma das funções do EGO “administrar” essa busca por satisfação do ID, enquanto tende a seguir as sanções impostas pelo SUPEREGO.

Em resumo, a teoria psicanalítica costuma atribuir ao Id as seguintes características:

- não faz planos e não espera;
- não tem cronologia (passado ou futuro), é sempre **presente**;
- por ser presente, busca uma satisfação imediata para impulsos e tensões;
- rege-se, portanto, pelo **princípio do prazer**;
- não aceita frustrações e não conhece inibição;
- não tem contato com os limites impostos pela realidade;
- busca satisfação inclusive na fantasia;
- pode ter o mesmo efeito de uma ação concreta para atingir um objetivo;
- é todo **inconsciente**.

4.2. O SUPEREGO

O SUPEREGO é a instância psíquica que, através do EGO, busca controlar o ID.

O SUPEREGO é uma modificação do EGO que ainda não se encontra desenvolvido o suficiente para atender às exigências do ID. O SUPEREGO é responsável por imposição de sanções, normas e padrões, e tem sua formação pela introjeção dos conteúdos (superegóicos) advindos dos pais.

Em outras palavras, o SUPEREGO controla regras sociais e morais que buscam domesticar aquilo que, no ID, é puro desejo e pulsão. Se o ID realizasse no mundo toda esta energia (de busca por satisfação de pulsões primitivas), a vida social seria impraticável (o EGO seria punido, por isso o SUPEREGO se antecipa, para restringir os impulsos do ID).

O SUPEREGO busca, portanto, a perfeição moral reguladora e tende a reprimir fortemente toda e qualquer contravenção ou infração que possa causar prejuízo ao dinamismo psíquico. Nesse sentido, por possuir parte consciente e parte inconsciente, quanto mais imerso ao lcs a representação do caráter moral do SUPEREGO estiver, mais resistentes e poderosas serão as sanções aos desvios morais.

O superego é parte consciente, parte inconsciente:

- **Exemplo de consciência:** quando você expressa “é proibido matar”.

- **Exemplo de inconsciência:** padrões de conduta e vestimenta que você julga serem uma escolha “natural” e sobre as quais você nunca pensou que foram determinadas de fora.

Diz-se que **o superego é o herdeiro do Complexo de Édipo**.

Isso quer dizer que o Édipo é uma experimentação complexa de limites impostos pela micro-sociedade familiar. Estes princípios serão importantes para a compreensão do sujeito diante dos acordos e desacordos com a vida social, inclusive exterior à família.

Ou seja, o superego é relacionado ao Complexo de Édipo porque seu mecanismo de funcionamento se desenvolve sobretudo a partir da idade do Édipo (em torno de 3 anos de idade até início da adolescência). É uma idade em que o filho precisa:

- entender o pai como garantidor das regras (limites, horários, disciplina etc.) refreadoras de sua pulsão;
- adotar um respeito reverencial pelo pai, como exemplo de herói, não mais um rival; e
- introjetar a proibição do incesto (desistir da mãe como objeto sexual).

Até que, depois, a criança vai crescendo e, na passagem para a adolescência, descubre que a sociedade tem muitas outras regras morais e fontes de admiração, diferentes do que vivia no ambiente familiar, mas com mecanismo similar, ao qual o superego já está habituado. A importância do Édipo para o desenvolvimento psicossocial é muito grande, porque será a

primeira experiência do sujeito com seu superego: as interdições e os ideais legitimados.

Depois, este adolescente já terá um superego mais complexo, com interdições e heróis vindos de outras partes, de modo a poder se afastar da mãe e do pai. Esta autonomização em relação à família e a introjeção de um superego complexo são bem típicos da adolescência: os pais costumam não gostar do afastamento do adolescente do berço, mas isso é um sinal de um Édipo bem resolvido e de uma maturação psíquica do filho.

Costuma-se dizer que o superego se estabelece por uma dinâmica entre o **ideal de “eu”** que a sociedade (desde a vida familiar) impõe ao sujeito e o **eu ideal** que o próprio sujeito introjeta e passa a se cobrar para ser e cumprir.

O superego tem três objetivos:

- inibir (através de punição ou sentimento de culpa) impulsos contrários às regras e ideais por ele ditados (consciência moral);
- forçar o ego a se comportar de maneira moral (mesmo que irracional);
- conduzir o indivíduo à “perfeição”, seja em gestos ou pensamentos.

Muito importante dizermos que um **superego rígido** é motivo de adoecimento psíquico e é uma das principais causas das neuroses, angústias, ansiedades. Isso porque o sujeito-analisando passa a se cobrar a seguir determinados desejos com os quais, em essência, não se identifica.

A terapia psicanalítica vai trabalhar contra um superego rígido, no sentido de *parar de desejar os desejos dos outros e passar a desejar o que identifica como “seu”*. Ou seja, numa sequência de sessões de psicanálise, um

dos principais objetivos para um maior bem-estar psíquico do sujeito analisando é ele:

- questionar os ideais de “eu” que estejam trazendo tensões psíquicas; e
- criar as condições para que se identifique em relação à sua própria ordem desejante.

Com isso, queremos dizer que entender a existência de um superego não significa aceitar todas as regras, leis, crenças e padrões de uma determinada família ou uma determinada sociedade.

Pelo contrário, significa sim entender que a vida social demanda convenções para evitar a barbárie (isto é, evitar o domínio do mais forte), mesmo quando essas convenções não estejam expressas ou escritas, mas que estas convenções não são sempiternas, imutáveis.

4.3. O EGO

Para Freud, o nascimento do EGO advém da primeira infância, onde os laços afetivo/emocionais com os “pais” são substancialmente intensos. Ou seja, essas experiências que se figuram na forma de orientações, sanções, ordens, proibições, entre outros, vão fazer com que a criança introjete e registre no inconsciente essas emoções subjetivas, e que darão “corpo” à sua estrutura psíquica e, sobretudo, na formação de uma estrutura egóica.

Desse modo, o EGO é uma diferenciação do ID (surge a partir do ID). Constituído de traços mnêmicos antigos (lembranças afetivas da infância), o

EGO possui sua maior parte consciente, mas também ocupa um espaço no inconsciente. É, portanto, a principal instância psíquica e que tem por funcionalidades **mediar, integrar e harmonizar** as constantes pulsões do ID, as exigências e ameaças do SUPEREGO, além das demandas provenientes do mundo externo (forçando-nos o processo identitário de “ser alguém” perante si mesmo e o mundo externo).

“O pobre do ego passa por coisas ainda piores: ele serve a três severos senhores e faz o que pode para harmonizar entre si seus reclamos e exigências. Esses reclamos são sempre divergentes e frequentemente parecem incompatíveis. Não é para admirar se o ego tantas vezes falha em sua tarefa. Seus três tirânicos senhores são o mundo externo, o superego e o id” (FREUD, 1932).

Incansavelmente, o EGO, enquanto instância psíquica, lança mão de atributos que o tornam fundamental na dinâmica do funcionamento do aparelho psíquico (ZIMERMAN, 1999):

- **Funções essenciais (parte consciente)** como percepção, memória, atenção, antecipação, pensamento, linguagem e comunicação, entre outros, na tentativa de buscar adaptabilidade ao mundo externo;
- **Funções mais complexas (parte inconsciente)** como na produção das angústias, mecanismos de defesa, fenômenos de identificações e formação de símbolos.
- **Representação e estruturação** da identidade do sujeito.

VALENTE (2002) sugere uma interessante analogia sobre a relação do ID e do EGO:

“(...) Freud comparou [a relação EGO e ID] à relação entre um cavaleiro e sua montaria. Geralmente o cavaleiro domina e dirige a sua montaria por onde ele quer. Isso acontece quando o cavaleiro é forte e experimentado. Do contrário, a montaria domina o cavaleiro e vai por onde ela quer. No primeiro caso, trata-se de um ego fortalecido, bem-treinado, bem-formado, de pessoa normal e sadia, com um id submisso, disciplinado e obediente; no segundo caso, teremos um id prepotente, insubmisso, indisciplinado e desobediente, diante de um ego enfraquecido, imaturo ou dissociado, subdesenvolvido, indeciso e medroso diante da insegurança, quando obrigado a tomar uma decisão consciente e racional, a ponto de deixar-se arrastar pela imposição do id.” (VALENTE, 2002, p. 96).

O EGO, portanto, é orientado pelo **princípio da realidade**, ou seja, é parte fundamental da sua constituição manter uma regulação egóica, no sentido de conter e retardar a satisfação imediata (proveniente do ID) e tolerar, inevitavelmente, o desprazer dessa impossibilidade.

De fato, grandes conflitos entre o ID, EGO e SUPEREGO determinarão a constituição de uma subjetividade (ou forma de funcionamento psíquico) neurótica, psicótica ou perversa, como veremos com detalhes no módulo III. Sendo assim, e considerando as funções egóicas instaladas dentro do funcionamento psíquico, há que se entender que, dentro do funcionamento da estrutura do EGO, existem mecanismos que vão possibilitar à pessoa o

estabelecimento de uma relação com o mundo (normal ou patológica), mas que garanta sua sobrevivência psíquica a fim de evitar o colapso.

Assim como o superego, **o ego também é:**

- parte consciente: quando raciocinamos ao falar em público, por exemplo;
- parte inconsciente: como os mecanismos de defesa do ego.

O **superego é considerado como uma especialização do ego**. Isso significa que:

- primeiro (ao nascer), **somos apenas Id**;
- depois, passamos a entender a **existência de um “eu” (ego)**, que se distingue do útero, da mãe e da realidade circundante;
- por fim, parte do ego se especializa para exercer a **função de superego**, introjetando os ideais e interdições aprendidos do meio social.

Achamos importante recomendar que você **não pense Id, ego e superego como três “seres” ou partes extremamente estanques em nossa mente**. Na verdade, o aparelho psíquico é *uno*, e essas três instâncias nos ajudam a entender determinadas especializações que cumprem determinadas funções.

Além disso, é difícil dizer que três partes (“pedaços”) bem delimitadas do cérebro respondam por estas especializações da vida mental. Embora sejam promissores determinados estudos “neuro” (neurologia, neurobiologia, neuropsicanálise etc.) para mostrar que determinadas áreas do cérebro tendem a ter uma atividade mais inconsciente, ou mais consciente, ou mais moral etc., por outro lado entende-se que o cérebro apresenta uma grande elasticidade (capacidade de se “redesenhar” e se adaptar, com por exemplo após acidentes cerebrais) e essas funções mentais podem não ser tão restritas a certos lugares específicos do cérebro.

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- **Artigo:** [Id, Ego e Superego](#)
- **Artigo:** [Superego segundo Freud](#)
- **Artigo:** [Conceito de Ego em Psicanálise](#)

4.3.1. Os mecanismos de defesa do EGO

Parte fundamental da estrutura do EGO, os mecanismos de defesas egóicas “(...) *designam-se os distintos tipos de operações mentais que têm por finalidade a redução das tensões psíquicas internas*” (ZIMERMAN, 1999, p. 128).

Portanto, são artifícios desenvolvidos dentro da dinâmica do aparelho psíquico, para que as relações entre suas instâncias ocorram de modo a proteger o psiquismo de ameaças que o levem ao colapso, à desintegração. Cada indivíduo, dentro da sua subjetividade desenvolvida ao longo da primeira infância, vai encontrar seus mecanismos e, através da parte inconsciente do EGO, será capaz de estabelecer e manter, qualitativamente, sua relação intrapsíquica e interpsíquica.

São mecanismos de defesa do EGO:

- **Recalcamento ou repressão:** o recalque nasce do conflito entre duas instâncias “opostas”: as exigências do ID e a censura do SUPEREGO. Ora, se ao EGO coube o trabalho de proteger a psique das energias destrutivas, é nesse contexto que conteúdos potencialmente nocivos (representações e afetos, atuais ou mnêmicos) e/ou intoleráveis são, inconscientemente, reprimidos pelo EGO e jogados ao obscuro do inconsciente, em uma constante luta, cujo objetivo é o de fugir ao desprazer causado pelo conflito.

- **Negação:** é umas das defesas mais arcaicas, e que, por isso, acomete o ego ainda bastante fragilizado, pouco evoluído. Esse mecanismo consiste em negar extensivamente a realidade exterior e, como proposta, a substitui pela criação de outra realidade ficcional. É uma defesa manifestada em subjetividades psicóticas. Foi bastante abordada por outros autores; Lacan, por exemplo, denominou essa defesa como “forclusão”.
- **Renegação / Denegação / Recusa:** trata-se de uma forma de negação, porém menos “agressiva” que a forclusão psicótica. Na renegação (ou denegação ou reclusa), o rompimento com a realidade ocorre de maneira parcial, ou seja, acomete apenas parte da estrutura do EGO. É uma defesa tipicamente encontrada em *subjetividades perversas*, nas quais há uma negação do conhecimento da verdade. Contudo, no fundo, o perverso sabe que essa verdade existe. Nesse sentido, difere da negação absoluta (do ponto anterior), que o psicótico crê totalmente na realidade criada.

Associe:

Negação / Forclusão	Renegação / Negação / Recusa
Total (rompimento absoluto com a realidade)	Parcial (rompimento parcial com a realidade)
Relação com a <i>psicose</i>	Relação com a <i>perversão</i>

- **Regressão:** essa defesa se manifesta quando o EGO consciente não é capaz de manter o controle de uma situação que lhe ofereceu ameaça à sua integridade. Desse modo, surge uma regressão aos chamados pontos de fixação (determinados estágios definidos pelas fases de desenvolvimento psicosssexual), fazendo com que o sujeito remeta a um funcionamento primitivo/infantil, de acordo com seu ponto de referência infantil.
- **Conversão orgânica:** nessa defesa, os conflitos psíquicos provenientes de algum impedimento (realização de desejo) e/ou trauma advindos de experiências (ou fantasias) afetivamente aflitivas buscam no *soma* (corpo) a possibilidade de descarga dessa pulsão reprimida. Nesse contexto, o sintoma físico apresenta um correspondente simbólico associado ao fato traumático (de origem sexual). “Somatizar” significa a expressão física de aflições da vida psíquica.
- **Projeção:** é um dos mecanismos mais comumente encontrados.

Consiste em *transferir* tudo aquilo que, por meio dos conflitos internos,

não é aceitável pelo EGO. Desse modo, as pulsões (agressivas ou sexuais) são projetadas para o exterior, atribuindo essas características intoleráveis a outros objetos (pessoas ou coisas).

- **Deslocamento:** podemos pensá-lo como uma variante da projeção; nesse mecanismo, os impulsos sexuais e de agressividade gerados na relação com algum objeto, e que por algum motivo não podem ser direcionados a ele, são deslocados a outros objetos, que viram alvos dessas “descargas não realizadas”.
- **Racionalização:** Frequentemente utilizada pelo EGO consciente, essa defesa consiste em uma elaboração racional (lógica) de eventos, percepções ou experiências que não podem ser compreendidas pelo psiquismo. Desse modo, todo um constructo racional é elaborado para dar cabo desses conteúdos incompreendidos.
- **Formação reativa:** uma manifestação que fora recalcada, em virtude do potencial sofrimento, é substituída por uma reação *oposta*, como forma de lidar com a dificuldade em enfrentar esse sentimento. Como uma pessoa cruelmente violenta (inconscientemente reprimida) age de maneira extremamente dócil.

- **Sublimação:** nesse mecanismo, as pulsões potencialmente destrutivas são, por assim dizer, modificadas ou sublimadas e, com isso, passam a adquirir uma realização positiva, socialmente aceita pela sociedade. Por exemplo, uma energia pulsional com potencial destrutivo é transformada pelo EGO em um trabalho compulsivo ou em uma obra artística (atividades que podem ser vistas como tendo uma “utilidade social”). A sublimação é um direcionamento da energia pulsional que esteja sem representação, para um investimento psíquico considerado relevante para a vida em sociedade, como o trabalho e as artes.

4.3.1 - Os mecanismos de defesa

- Recalcamento ou repressão
- Negação
- Renegação/Denegação/Recusa
- Conversão orgânica
- Projeção
- Deslocamento
- Racionalização

REVISÃO MÓDULO 02

4.3.1 - Os mecanismos de defesa

- Deslocamento
- Racionalização
- Formação reativa
- Sublimação

REVISÃO MÓDULO 02

INDICAÇÃO DE LEITURA (OPCIONAL)

- Artigo: [Mecanismos de Defesa](#)
- Artigo: [Recalcamento e o Retorno do Recalcado](#)
- Artigo: [Sublimação segundo a psicanálise](#)
- Artigo: [Racionalização como mecanismo de defesa](#)

INDICAÇÃO DE LEITURA:

2.5 - Ler o Artigo: O modelo estrutural de Freud e o cérebro: uma proposta de integração entre a psicanálise e a neurofisiologia (2009). [8 páginas]

[Clique aqui para ler](#) ou acesse <https://bit.ly/2p6kCgL>

5. Breves reflexões acerca da Ética do Psicanalista

Teremos um módulo completo do Curso para aprofundar o tema da ética do psicanalista. Além disso, pela importância do assunto, veremos alguns dos pontos desta temática no decorrer dos demais módulos.

Por enquanto, é fundamental extrair alguns desdobramentos sobre ética, a partir do que foi visto neste módulo.

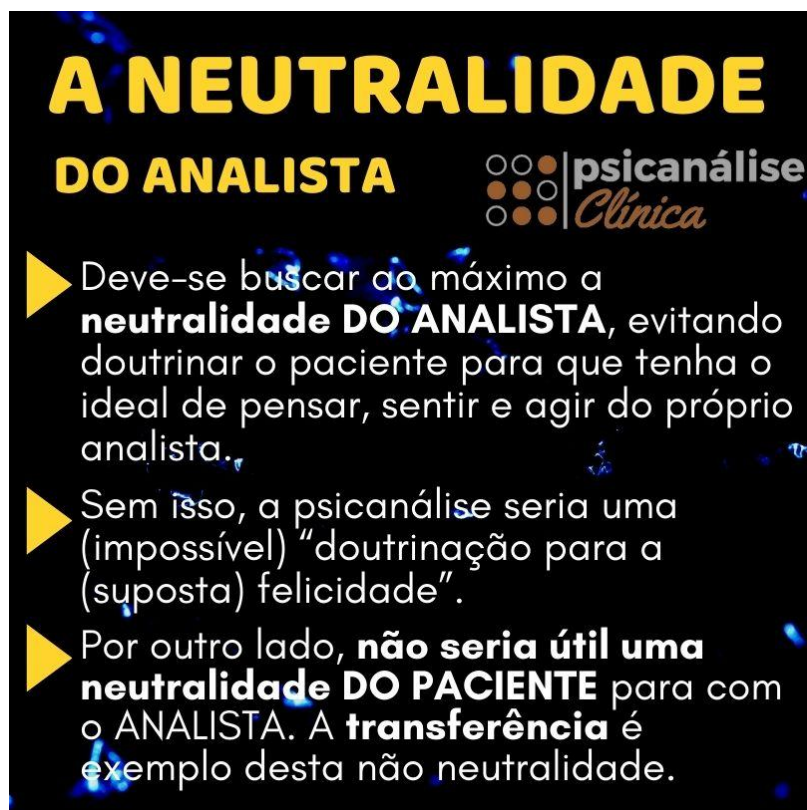
A psicanálise defende que se busque ao máximo a **neutralidade DO ANALISTA**: deve o analista evitar doutrinar o paciente para que tenha o ideal de pensar, sentir e agir do próprio analista. Sem uma busca de neutralidade do analista, a psicanálise poderia se converter em uma impossível “doutrinação para a (suposta) felicidade”.

Seria um flagrante caso de falta de ética, de falta de profissionalismo e de narcisismo exacerbado do psicanalista caso o psicanalista julgue “senhor” de suas verdades ideológicas ou religiosas e passe a exercer como “missão” transmitir tais verdades de forma implícita ou explícita aos seus pacientes. O “psicanalista” sequer poderia se chamar assim, pois estaria fazendo qualquer outra coisa, menos psicanálise.

Apesar de buscar uma neutralidade do analista, a psicanálise entende como inevitável e até mesmo útil o que podemos chamar de “**pessoalidade**”

ou **falta de neutralidade do paciente** para com o analista. Disso é exemplo a transferência.

Como vimos, a transferência quebra certa frieza e “mesmice” da neutralidade DO PACIENTE, que começa a reproduzir no setting analítico os comportamentos e pensamentos tais como o faria em sua “vida cotidiana”.



A NEUTRALIDADE DO ANALISTA



- ▶ Deve-se buscar ao máximo a **neutralidade DO ANALISTA**, evitando doutrinar o paciente para que tenha o ideal de pensar, sentir e agir do próprio analista.
- ▶ Sem isso, a psicanálise seria uma (impossível) “doutrinação para a (suposta) felicidade”.
- ▶ Por outro lado, **não seria útil uma neutralidade DO PACIENTE** para com o ANALISTA. A **transferência** é exemplo desta não neutralidade.

A experiência é importante para o analista. Mas não é por ser experiente ou inexperiente que a transferência será boa ou ruim à terapia. O que importa é o **manejo adequado da transferência**, além da importância de o psicanalista ser supervisionado por outro psicanalista mais experiente que lhe auxilie na orientação sobre os casos clínicos.

A transferência poderá ser positiva ou negativa tanto no atendimento aos pacientes neuróticos (a “maioria”) quanto aos perversos ou aos psicóticos.

Enquanto muitos teóricos consideram que a psicanálise tem bons resultados tanto no atendimento aos neuróticos quanto aos perversos ou aos psicóticos, outros entendem que a psicanálise é um tratamento essencialmente das neuroses.

Assim, podem existir analistas que (por formação ou convicção) preferem não atender pacientes em psicose. Determinada escolha é compreensível e não se caracteriza uma falta de ética, já que compete ao analista avaliar acerca de quais tipos de casos e quais demandas de pacientes o analista está preparado para atender.

Um outro aspecto relacionado à temática da ética é o **exercício do tripé psicanalítico**. É imprescindível que o psicanalista em atuação clínica siga exercendo o tripé psicanalítico (mesmo depois de formado):

- estudando a **teoria** (cursos e livros);
- fazendo sua **análise pessoal** com outro psicanalista
- sendo **supervisionado** por outro psicanalista mais experiente, para acompanhar os casos que estiver atendendo.

Assim, o tripé psicanalítico é uma **obrigação a todo psicanalista que decida atuar no atendimento a pacientes**. Ou seja, seguir o tripé psicanalítico depois de formado é uma obrigação, não é opção, no caso de se atuar como psicanalista.

Ao não seguir o tripé psicanalítico (seguir estudando, sendo supervisionado e analisado) depois de formado, o analista em atuação clínica inscreve-se fora da tradição psicanalítica.

TRIPÉ DA PSICANÁLISE

É fundamental que o psicanalista em atuação clínica siga exercendo o **tripé psicanalítico** (mesmo depois de formado):

- 
- ▶ 1. estudando a **teoria** (cursos e livros);
 - ▶ 2. fazendo sua **análise pessoal** com outro psicanalista
 - ▶ 3. sendo **supervisionado** por outro psicanalista mais experiente, para acompanhar os casos que estiver atendendo.

Caso o formado em psicanálise não pretenda atuar com atendimento clínico, seguir o tripé não é obrigatório. Mas, ainda que não pretenda atuar em clínica, é essencial que o formado em psicanálise siga pelo menos com novos estudos por cursos e livros (teoria) e fazendo sua análise pessoal, para seu autoconhecimento e enfrentamento de suas questões psíquicas.

6. Quizzes (Enquetes)

Estamos adicionando quizzes (enquetes) nos módulos. O módulo 2 conta com as enquetes abaixo. Servem para revisar e fixar conteúdos.

Importante: a prova do módulo (contendo 10 perguntas de múltipla escolha e uma redação) é diferente das enquetes (que são perguntas de verdadeiro ou falso). As partes obrigatórias para você concluir o Curso de Formação são as 12 provas (uma por módulo), não as enquetes abaixo. As enquetes servem de revisão e fixação do aprendizado.

As enquetes abaixo são somente afirmações, sobre as quais você deve responder **Verdadeiro ou Falso**. A resposta é feita no Telegram do projeto Psicanálise Clínica. Isso porque o Telegram tem o recurso interativo de enquetes: você responde e, depois, pode verificar se acertou e **pode também ler um comentário explicando a questão**.

Você deve clicar no link da enquete abaixo usando um celular com Telegram instalado (o Telegram é gratuito e você pode baixar em qualquer “loja” de aplicativos, como Google Play ou Apple Store), ou estando conectado no Web Telegram no seu computador.

Como ver a resposta? Depois de responder, atualize a página do Telegram (ou clique em outra conversa do Telegram e depois volte ao canal Psicanálise Clínica no Telegram) e **clique no desenho de lâmpada** que aparecerá entre a pergunta e a resposta, do lado direito: você já verá o gabarito com um breve comentário.



Clique nos links do Telegram abaixo, usando um celular com Telegram instalado, ou estando conectado no Web Telegram no seu computador.

Depois de responder, atualize a página do Telegram (ou clique em outra conversa e depois volte ao canal Psicanálise Clínica no Telegram) e **clique no desenho de lâmpada** que aparecerá entre a pergunta e a resposta, do lado direito: você já verá o gabarito com um breve comentário.

[Módulo 2, Quiz 1] Charcot, médico vienense, foi confidente de Freud ao longo de seu amadurecimento enquanto psicanalista, atuando lado a lado de Freud na obra A Interpretação dos Sonhos.

() Verdadeiro

() Falso

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1145>

**Obs.: todos os quizzes seguintes são também baseados em enunciados, para os quais deve-se atribuir Verdadeiro ou Falso.*

[Módulo 2, Quiz 2] O período que, segundo alguns biógrafos de Freud, ficou conhecido como “autoanálise de Freud” refere-se a um período em que Freud buscava compreender seus medos, anseios e dores, exclusivamente por meio de auto-hipnose.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1151>

[Módulo 2, Quiz 3] Neuroses atuais são patologias que se atualizam no presente por apresentar um representante psíquico vinculado ao passado.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1159>

[Módulo 2, Quiz 4] Neuroses atuais são patologias que possuem um correspondente vinculado às frustrações sexuais, pelo excesso ou inibição, e não apresentam origem na infância.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1165>

[Módulo 2, Quiz 5] As psiconeuroses são patologias que começam e terminam na vida infantil de uma pessoa.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1168>

[Módulo 2, Quiz 6] As psiconeuroses são patologias cuja origem estariam nas vivências infantis de natureza traumática. Segundo Freud, embora sua origem seja na infância, as decorrências podem perdurar pela vida adulta.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1183>

[Módulo 2, Quiz 7] A psicanálise considera que as fobias sejam tipos de neuroses atuais, porque nunca guardam relação com eventos da infância.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1186>

[Módulo 2, Quiz 8] Neuroses atuais e psiconeuroses são tipos de neuroses elencadas por Freud; Freud exclui o conceito de psicose até então conhecido, ao rejeitar por completo a psicose como conceito ou como patologia.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1190>

[Módulo 2, Quiz 9] O psicanalista que tem autoestima elevada e está convicto de suas verdades será um bom terapeuta por si mesmo, por isso poderá optar por não seguir estudando, nem sendo analisado, nem sendo supervisionado.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1197>

[Módulo 2, Quiz 10] “Pare de me fazer perguntas e me deixe falar”.

Esta frase, atribuída a Emmy Von N. (paciente de Freud), é lembrada como um dos momentos importantes para que Freud fosse atribuindo cada vez mais importância à fala do analisando.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1204>

[Módulo 2, Quiz 11] A paciente Emmy Von N. é lembrada como a

primeira paciente de Freud em que este analista empregou exclusivamente o método da associação livre, já na fase de maturidade da obra de Freud.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1207>

[Módulo 2, Quiz 12] No método psicanalítico da associação livre, o

paciente deve ser repreendido pelo analista a cada vez que muda de assunto, para que sua mente aprenda a focar no que é importante.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1212>

[Módulo 2, Quiz 13] Freud identificou que sugestões hipnóticas e

explicações unilaterais do analista não eram suficientes no tratamento. Isso

motivou Freud a deixar o paciente falar mais, para que este desencadeasse ideias de forma mais livre.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1216>

[Módulo 2, Quiz 14] A associação livre pressupõe o foco na associação puramente lógica e consciente da fala do analisando, que leva ao inconsciente, graças ao estado semi-hipnótico.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1224>

[Módulo 2, Quiz 15] Os principais autores da psicanálise contemporânea defendem que o psicanalista hoje pode usar seja o método da associação livre, seja o método da sugestão hipnótica, que levam exatamente aos mesmos resultados.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1233>

[Módulo 2, Quiz 16] Psicose e perversão são tipos de neuroses, segundo Freud.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1240>

[Módulo 2, Quiz 17] O tripé psicanalítico (teoria por cursos e livros, ser analisado por outro psicanalista e ser supervisionado em seus casos por psicanalista mais experiente) é uma obrigação a todo psicanalista que decida atuar no atendimento a pacientes.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1252>

[Módulo 2, Quiz 18] Para a psicanálise, o diálogo terapêutico só serve para tornar mais agudas as dores psíquicas que são lembradas. Por isso, o tratamento baseia-se na maior parte do tempo em tentativas de o analista convencer e suggestionar o analisando.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1258>

[Módulo 2, Quiz 19] Embora as perguntas sejam relevantes como recurso discursivo na terapia psicanalítica, a fala do psicanalista no *setting* terapêutico não se resume apenas a fazer perguntas para o analisando responder.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1263>

[Módulo 2, Quiz 20] Ocorre a transferência (no conceito psicanalítico) quando o paciente troca de analista. Essa troca de analista deve ser feita toda vez que houver qualquer ruído na interação entre paciente e terapeuta.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1278>

[Módulo 2, Quiz 21] A repressão é a técnica que o analista tem para reprimir as ideias equivocadas que o paciente faz de si mesmo, sugestionando o paciente para que jogue essas ideias definitivamente para o inconsciente inalcançável.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1245>

[Módulo 2, Quiz 22] Inicialmente vista como um limitante, a transferência assume papel central na dinâmica analista-paciente, uma vez que o paciente transmite seus conflitos inconscientes à figura do analista e, assim, pode favorecer muitos materiais para o trabalho psicanalítico.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1283>

[Módulo 2, Quiz 23] A psicanálise defende que se busque ao máximo a neutralidade DO ANALISTA, evitando doutrinar o paciente para que tenha o ideal de pensar, sentir e agir do próprio analista.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1287>

[Módulo 2, Quiz 24] O psicanalista que tem autoestima elevada e está convicto de suas verdades ideológicas ou religiosas será um bom terapeuta por

si mesmo, bastará transmitir essas verdades de forma implícita aos seus pacientes.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1294>

[Módulo 2, Quiz 25] Apesar de buscar uma neutralidade do analista, a psicanálise entende como inevitável e até mesmo útil o que podemos chamar de “pessoalidade” ou falta de neutralidade do paciente para com o analista. Disso é exemplo a transferência.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1303>

[Módulo 2, Quiz 26] Vista como limitante no início dos constructos psicanalíticos, a transferência passará a ser vista depois como sendo sempre positiva quando o paciente sofre de neurose e sempre negativa quando o paciente sofre de psicose.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1316>

[Módulo 2, Quiz 27] A transferência representa a troca de papéis entre terapeuta e analisando. Ou seja, o terapeuta começa a agir como se fosse o analisando, e então o analisando pode ver quão ridículos são seus pensamentos e comportamentos.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1321>

[Módulo 2, Quiz 28] Para Freud, as fobias são, em essência, um tipo de psiconeurose, haja vista sua correspondência a eventos potencialmente traumáticos na infância, que encontram nos representantes fóbicos uma forma de substituição.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1334>

[Módulo 2, Quiz 29] A transferência só terá chance de ser positiva se o psicanalista tiver anos de experiência no trabalho clínico.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1340>

[Módulo 2, Quiz 30] Para Freud, um mecanismo comum à histeria, fobia e obsessão é a incapacidade de elaboração frente a uma experiência ou sentimento aflitivo(a), o que faz com que uma representação “esquecida” seja elaborada psiquicamente de outra maneira.*

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1345>

[Módulo 2, Quiz 31] Um sentido possível de “psicanálise selvagem” (Freud) é o analista usar interpretações de cunho puramente superficial e dogmático, deixando de escutar seu paciente de forma cautelosa e investigativa.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1353>

[Módulo 2, Quiz 32] A sublimação pode ser entendida como um direcionamento da energia pulsional que esteja sem representação, para um investimento psíquico considerado relevante para a vida em sociedade, como o trabalho e as artes.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1365>

[Módulo 2, Quiz 33] Ao não seguir o tripé psicanalítico (seguir estudando, sendo supervisionado e analisado) depois de formado, o analista inscreve-se fora da tradição psicanalítica.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1369>

[Módulo 2, Quiz 34] Em psicanálise, costuma-se chamar de “resistência” o esforço exclusivamente consciente que o paciente faz em entender suas dores psíquicas e superar sua autossabotagem durante a terapia.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1372>

[Módulo 2, Quiz 35] Os sonhos são formados por elaborações a partir de estímulos sensoriais provenientes tanto do meio interno (psíquico) como do

meio externo, por acontecimentos vividos em vigília e conteúdos reprimidos a nível inconsciente.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1376>

[Módulo 2, Quiz 36] Os sonhos podem ser compreendidos como sendo uma estrada, ou via régia, que emerge exclusivamente de uma interpretação literal do mundo consciente (pensamento, percepção e raciocínio) de quem sonha.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1380>

[Módulo 2, Quiz 37] Os conteúdos oníricos (dos sonhos) transitam pelo conteúdo manifesto e conteúdo latente, sendo o primeiro caracterizado por imagens que podem ser lembradas (ou não) após acordar; e o segundo um conjunto de representações inconscientes.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1386>

[Módulo 2, Quiz 38] A construção do aparelho psíquico da 1ª tópica é rejeitada e substituída integralmente por Freud ao propor a 2ª tópica, quando Freud apresentou os conceitos de ID, EGO e SUPEREGO.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1397>

[Módulo 2, Quiz 39] A 1ª tópica freudiana é também chamada de Teoria Topográfica: vem de “topos” que significa lugar. A ideia de Freud era pensar um sistema em que as partes ocupassem lugares virtuais, cada qual com sua função determinada.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1401>

[Módulo 2, Quiz 40] O recalçamento é entendido como uma “primeira linha de defesa”, impedindo que conteúdos angustiantes venham à tona ao nível consciente, de maneira direta.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1409>

[Módulo 2, Quiz 41] O princípio do prazer é responsável por reger essencialmente as manifestações inconscientes; a energia pulsional visa à sua descarga por meio da satisfação ou prazer. Em teoria, costuma-se contrapor este princípio ao da “realidade”.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1449>

[Módulo 2, Quiz 42] O inconsciente opera segundo as leis do processo primário. Nele a energia psíquica fica aprisionada a nível inconsciente,

impedindo totalmente que isso transite entre as instâncias do aparelho psíquico.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1452>

[Módulo 2, Quiz 43] O SUPEREGO é uma especialização do EGO que fica restrito ao campo do consciente, impossibilitando seu acesso ao inconsciente.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1459>

[Módulo 2, Quiz 44] O EGO é a instância psíquica responsável por “negociar” as demandas do ID e do SUPEREGO, de modo que os mecanismos de defesas do ego atuam na tentativa de mediar as tensões psíquicas.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1464>

[Módulo 2, Quiz 45] A histeria de conversão é um mecanismo de defesa do EGO que é responsável por converter as pulsões somente em produções socialmente aceitas.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1468>

[Módulo 2, Quiz 46] A neurobiologia tem emergido como possibilidade de diálogo com a psicanálise rumo a uma melhor compreensão sobre as questões de funcionamento da mente.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1473>

[Módulo 2, Quiz 47] A prepotência de “sentir-se pronto” e não seguir o tripé psicanalítico depois de formado tende a provocar contratransferências inadequadas e manejos “selvagens”.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1478>

[Módulo 2, Quiz 48] Embora áreas do conhecimento distintas, psicanálise e neurociência são capazes de olhar para um fenômeno sobre suas óticas sem que necessariamente se excluam. Há potenciais cada vez mais complementares e mutuamente enriquecedores.

Responda este quiz no Telegram: <https://t.me/psicanaliseclinica/1479>

7. Referências bibliográficas

ARNAO, M. **A distinção entre representação de palavra e representação de coisa na obra freudiana**. In: *Ágora* (Rio J.) v.11 n.2 Rio de Janeiro jul./dez. 2008, <<https://doi.org/10.1590/S1516-14982008000200002>>, consultado em 13.mar.2020.

BOCK, A. M. et al. **Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia**. São Paulo: Saraiva, 2001.

COLLIN, C.; GRAND, V.; BENSON, N.; LAZYAN, M.; GINSBURG, J.; WEEKS, M. **O livro da Psicologia**. Rio de Janeiro: Editora Globo, 2012.

FINE, R. **A história da psicanálise**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1981.

FREUD, S. **Estudos sobre a histeria (1893)**. Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

_____ **A interpretação dos sonhos (1900)**. Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

_____ **Psicopatologia da vida cotidiana (1901)**. Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

_____ **Chistes e a sua relação com o Inconsciente (1905)**. Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

_____ **Um estudo autobiográfico (1925).** Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

_____ **Novas conferências introdutórias sobre a psicanálise (1932).** Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

LAPLANCHE, J; PONTALIS, J. B. **Vocabulário da Psicanálise.** São Paulo: Martins Fontes, 1996.

MANNONI, O; **Freud: uma biografia ilustrada.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.

PAI da psicanálise foge da loucura. *O Globo*, Rio de Janeiro, n. 14, 2000,

Um breve histórico de histeria: de Freud a Lacan. In: REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE PSICOLOGIA, ISSN: 1806-0625, Ano VII, Número 13, 2009.

VALENTE, N; **Psicanálise freudiana: uma análise atual ao alcance de todas as mentes.** São Paulo: Ed. Panorama, 2002.

VENTURA, Rodrigo. **Os paradoxos do conceito de resistência: do mesmo à diferença.** *Estud. psicanal.*, Belo Horizonte, n. 32, nov. 2009 .

WOLLHEIM, R. **As ideias de Freud.** São Paulo: Círculo do Livro, 1971.

ZIMERMAN, D. E. **Fundamentos Psicanalíticos: Teoria, técnica e clínica.** Porto Alegre: Artmed, 1999.